

سوال ۱

سوال: خانم ۶۴ ساله با شکایت درد انگشتان دست چپ و تشدید آن با انجام کارهای روزانه مراجعه می کند. در معاینه برجستگی در مفاصل دیستال انگشتان وجود دارد. تشخیص احتمالی شما کدام است؟

- الف) آرتريت روماتوئيد
- ب) استئوآرتريت ندولار
- ج) لوپوس
- د) نقرس

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (آرتريت روماتوئيد): نادرست است.** آرتريت روماتوئيد (RA) به طور مشخص مفاصل اینترفالانژیال دیستال (DIP) یا همان مفاصل بند آخر انگشتان را درگیر نمی کند. برجستگی در مفاصل دیستال، مشخصه این بیماری نیست.
- **گزینه ب (استئوآرتريت ندولار): صحیح است.** برجستگی های استخوانی (ندول) در مفاصل دیستال انگشتان، "گره های هبردن" نام دارند و یکی از یافته های کلاسیک و مشخصه اصلی بیماری استئوآرتريت (آرتروز) هستند. تشدید درد با فعالیت نیز از دیگر ویژگی های آرتروز است.
- **گزینه ج (لوپوس): نادرست است.** اگرچه لوپوس می تواند مفاصل PIP را درگیر کند، اما ایجاد برجستگی های استخوانی در مفاصل دیستال از تظاهرات مشخصه آن نیست.
- **گزینه د (نقرس): نادرست است.** نقرس معمولاً با حملات حاد التهابی (قرمزی، تورم و درد شدید) به خصوص در مفصل شست پا (پوداگرا) ظاهر می کند. هرچند در نقرس مزمن ممکن است توده هایی به نام توفوس ایجاد شود، اما برجستگی استخوانی در مفاصل دیستال که با فعالیت تشدید می شود، نمای کلاسیک نقرس نیست.

نکته کامل از درسنامه: معاینه دست و ندول های استئوآرتريت

در معاینه بالینی دست در بیماری های روماتولوژیک، توجه به ندول ها یا برجستگی های استخوانی اهمیت تشخیصی بالایی دارد. این ندول ها مشخصه ی اصلی استئوآرتريت (آرتروز) هستند.

- **پاتوفیزیولوژی ندول ها:** در استئوآرتريت، غضروف مفصلی تخریب می شود. در پاسخ به این تخریب، استخوان زیرین شروع به رشد اضافی در لبه های مفصل می کند و برجستگی های استخوانی به نام استئوفیت (Osteophyte) یا خار استخوانی را ایجاد می کند. این استئوفیت ها همان ندول هایی هستند که در معاینه لمس می شوند.
- **انواع ندول ها در استئوآرتريت:**

- **گره‌های هبردن (Heberden's nodes):** این برجستگی‌ها در مفاصل بند آخر انگشتان، یعنی مفاصل اینترفالانژیال دیستال (DIP)، ایجاد می‌شوند. وجود این گره‌ها قویاً به نفع استئوآرتریت است.
- **گره‌های بوشار (Bouchard's nodes):** این برجستگی‌ها در مفاصل بند وسط انگشتان، یعنی مفاصل اینترفالانژیال پروگزیمال (PIP)، دیده می‌شوند.
- **نکته بالینی کلیدی:** الگوی درگیری مفاصل در افتراق بیماری‌ها بسیار مهم است. آرتریت روماتوئید به طور مشخص مفاصل DIP را درگیر نمی‌کند. بنابراین، مشاهده گره‌های هبردن در مفاصل دیستال، یک سرنگ قوی برای تشخیص استئوآرتریت و رد کردن آرتریت روماتوئید است.

سوال ۲

سوال: از بیماری که به پشت خوابیده است می‌خواهیم اندام تحتانی خود را بالا بیاورد. اندام کمی حرکت می‌کند ولی بر خلاف نیروی جاذبه نمی‌تواند بالا بیاید. به قدرت عضلانی چه امتیازی می‌دهید؟

- الف) یک پنجم
- ب) دو پنجم
- ج) سه پنجم
- د) چهار پنجم

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (یک پنجم): نادرست است.** قدرت درجه ۱ (Trace) به معنی وجود انقباض خفیف عضله است، اما این انقباض قادر به ایجاد حرکت در مفصل نیست. در این بیمار، اندام "کمی حرکت می‌کند".
- **گزینه ب (دو پنجم): صحیح است.** قدرت درجه ۲ (Poor) به این معناست که عضله می‌تواند دامنه حرکتی کامل مفصل را تنها در صورتی انجام دهد که نیروی جاذبه حذف شده باشد (مثلاً حرکت اندام روی سطح تخت). بیمار می‌تواند اندام را حرکت دهد اما نه در برابر جاذبه، که این تعریف دقیقاً با قدرت درجه ۲ مطابقت دارد.
- **گزینه ج (سه پنجم): نادرست است.** قدرت درجه ۳ (Fair) به معنی توانایی انجام دامنه حرکتی کامل در برابر نیروی جاذبه است، اما نه در برابر مقاومت. بیمار در سوال قادر به غلبه بر نیروی جاذبه نیست.
- **گزینه د (چهار پنجم): نادرست است.** قدرت درجه ۴ (Good) به معنی توانایی انجام حرکت کامل در برابر جاذبه و مقاومت متوسط است.

نکته کامل از درسنامه: مقیاس MRC برای درجه‌بندی قدرت عضلانی

برای ارزیابی شدت ضعف عضلانی در بیماری‌هایی مانند درماتومیوزیت، از مقیاس استاندارد شورای تحقیقات پزشکی (Medical Research Council - MRC) استفاده می‌شود. این مقیاس که به آن "مقیاس Lovett" نیز گفته می‌شود، قدرت عضلانی را از ۰ تا ۵ درجه‌بندی می‌کند.

- **درجه 0 (Zero):**
 - **عملکرد:** هیچ شواهدی از انقباض عضله وجود ندارد (فلج کامل).
 - **درصد نرمال:** 0%.
- **درجه 1 (Trace - T):**
 - **عملکرد:** انقباض خفیف عضله قابل مشاهده یا لمس است، ولی این انقباض آنقدر قوی نیست که بتواند حرکتی در مفصل ایجاد کند.
 - **درصد نرمال:** 10%.
- **درجه 2 (Poor - P):**
 - **عملکرد:** عضله قادر است دامنه حرکتی کامل مفصل را انجام دهد، اما **فقط در صورتی که نیروی جاذبه حذف شود** (مثلاً حرکت دادن پا روی سطح تخت به جای بلند کردن آن).
 - **درصد نرمال:** 25%.
- **درجه 3 (Fair - F):**
 - **عملکرد:** عضله قادر است دامنه حرکتی کامل را **در برابر نیروی جاذبه** انجام دهد، اما نمی‌تواند بر هیچ مقاومتی غلبه کند.
 - **درصد نرمال:** 50%.
- **درجه 4 (Good - G):**
 - **عملکرد:** عضله قادر است دامنه حرکتی کامل را **در برابر جاذبه و مقاومت متوسط** انجام دهد.
 - **درصد نرمال:** 75%.
- **درجه 5 (Normal - N):**
 - **عملکرد:** عضله قادر است دامنه حرکتی کامل را **در برابر جاذبه و مقاومت کامل** انجام دهد (قدرت نرمال).
 - **درصد نرمال:** 100%.

سوال ۳

سوال: برای تشخیص سندرم تونل کارپال کدام تست انجام میشه؟

- **پاسخ صحیح:** فالن (Phalen)

پاسخ تشریحی:

بر اساس درسنامه ارائه شده، دو تست بالینی مهم برای ارزیابی سندرم تونل کارپال وجود دارد که یکی از آنها تست فالن (Phalen's Test) است. این تست برای تشخیص این سندرم استفاده می‌شود.

نکته کامل از درسنامه: تست‌های تشخیصی برای سندرم تونل کارپال (Carpal Tunnel Syndrome)

سندرم تونل کارپال یکی از شایع‌ترین نوروپاتی‌های فشاری است که به دلیل تحت فشار قرار گرفتن عصب مدین (Median Nerve) در ناحیه مچ دست رخ می‌دهد. دو تست بالینی مهم برای ارزیابی این سندرم در درسنامه ذکر شده است:

1. تست فالن (Phalen's Test):

- روش انجام:** از بیمار خواسته می‌شود تا مچ هر دو دست خود را در حالت فلکشن کامل (خم شده به سمت کف دست) قرار دهد و پشت دست‌ها را برای مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه به یکدیگر فشار دهد.
- مکانیسم و تفسیر:** این مانور باعث افزایش فشار داخل کانال کارپال می‌شود. اگر عصب مدین از قبل تحریک‌پذیر باشد، این افزایش فشار اضافی باعث بازتولید یا تشدید علائمی مانند بی‌حسی، گزگز یا درد در محدوده عصب‌دهی عصب مدین (انگشتان شست، اشاره، میانی و نیمه از انگشت حلقه) می‌شود. مثبت شدن این تست احتمال وجود سندرم تونل کارپال را به شدت بالا می‌برد.

2. علامت تینل (Tinel's Sign):

- روش انجام:** معاینه‌کننده با نوک انگشت یا چکش رفلکس کوچک، به آرامی روی مسیر عصب مدین در ناحیه مچ دست ضربه می‌زند.
- مکانیسم و تفسیر:** ضربه زدن به یک عصب تحریک‌شده یا آسیب‌دیده می‌تواند باعث ایجاد حس برق‌گرفتگی یا گزگز (پارستزی) در محدوده توزیع آن عصب شود. مثبت شدن این علامت نشان‌دهنده تحریک‌پذیری عصب مدین است.

یافته دیررس: آتروفی تنار (Thenar Atrophy):

- یافته بالینی:** تحلیل رفتن و صاف شدن برجستگی عضلانی در قاعده شست (برجستگی تنار).
- مکانیسم:** در موارد شدید و مزمن سندرم تونل کارپال، فشار مداوم بر روی عصب مدین منجر به آسیب آکسونی و قطع ارتباط عصب با عضلات تنار می‌شود. این وضعیت باعث تحلیل رفتن تدریجی این عضلات می‌گردد و یک علامت دیررس و نشان‌دهنده شدت بیماری است.

سوال ۴ (بر اساس تصویر و مفهوم در فایل‌های مختلف)

سوال: فشار دادن عرضی بر روی مفاصل بین کف دست و انگشتان (MCP) که باعث ایجاد درد در بیمار می‌شود، چه نام دارد و یافته کلیدی در تشخیص کدام بیماری است؟

- الف) تست فالن - سندرم تونل کارپال
- ب) تست فشار متاتارس - آرتريت پسوریاتیک
- ج) تست فشار متاکارپ (Metacarpal squeeze) - آرتريت روماتوئید
- د) علامت تینل - استئوآرتريت

پاسخ تشریحی:

- گزینه الف (تست فالن - سندرم تونل کارپال): نادرست است.** تست فالن شامل خم کردن کامل مچ دست برای تشخیص سندرم تونل کارپال است و ربطی به فشار دادن عرضی مفاصل MCP ندارد.
- گزینه ب (تست فشار متاتارس - آرتريت پسوریاتیک): نادرست است.** تست فشار مشابهی برای پاها (متاتارس‌ها) وجود دارد، اما این سوال به طور خاص به دست (متاکارپ‌ها) اشاره دارد.
- گزینه ج (تست فشار متاکارپ (Metacarpal squeeze) - آرتريت روماتوئید): صحیح است.** این مانور دقیقاً "تست فشار متقابل متاکارپ‌ها" نام دارد. مثبت شدن این تست (ایجاد درد) حساسیت بالایی برای وجود التهاب (سینوئیت) در مفاصل MCP دارد و یکی از یافته‌های کلیدی در تشخیص زودهنگام آرتريت روماتوئید است.
- گزینه د (علامت تینل - استئوآرتريت): نادرست است.** علامت تینل شامل ضربه زدن روی عصب برای تشخیص نوروپاتی فشاری (مانند سندرم تونل کارپال) است و ارتباطی با استئوآرتريت یا این مانور فشاری ندارد.

نکته کامل از درسنامه: تست فشار متقابل متاکارپ‌ها (Metacarpal Squeeze Test)

این تست یکی از مانورهای بالینی مهم در مرحله "لمس" (Palpation) معاینه دست است که برای تشخیص التهاب مفاصل متاکارپوفالانژیال (MCP) به کار می‌رود.

- روش انجام:** معاینه‌کننده کف دست بیمار را در دست خود گرفته و به آرامی سر استخوان‌های متاکارپ (مفاصل MCP) را از دو طرف به هم فشار می‌دهد.
- اهمیت بالینی و تفسیر:**
 - مثبت شدن این تست، که با ایجاد درد در مفاصل MCP مشخص می‌شود، حساسیت بالایی برای وجود **سینوئیت (التهاب غشای سینوئیل)** در این مفاصل دارد.

- این تست یکی از یافته‌های کلیدی در تشخیص زودهنگام آرتریت روماتوئید محسوب می‌شود، زیرا مفاصل MCP از جمله شایع‌ترین مفاصل درگیر در ابتدای این بیماری هستند. دردناک بودن این مفاصل در برابر فشار عرضی، یک سرخ مهم تشخیصی است.

سوال ۵ (از فایل: فیزیوپاتولوژی_روماتولوژی، بهمن_93 سوال ۳)

سوال: قرمزی سطح مفصل در کدامیک از بیماری‌های زیر نادر است؟

- الف) آرتریت روماتوئید
- ب) تب روماتیسمی
- ج) نقرس
- د) آرتریت واکنشی

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (آرتریت روماتوئید): صحیح است.** اگرچه آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی است و مفصل ممکن است گرم و متورم باشد، اما قرمزی شدید (اریتم) سطح مفصل، برخلاف بیماری‌هایی مانند نقرس یا آرتریت سپتیک، از ویژگی‌های معمول آن نیست. التهاب در آرتریت روماتوئید بیشتر باعث تورم خمیری شکل (ناشی از ضخیم شدن سینوویوم) می‌شود.
- **گزینه ب (تب روماتیسمی): نادرست است.** تب روماتیسمی باعث یک آرتریت حاد و مهاجر می‌شود که مفاصل درگیر به شدت ملتهب، دردناک، متورم و قرمز هستند.
- **گزینه ج (نقرس): نادرست است.** قرمزی شدید و براق بودن پوست روی مفصل یکی از علائم کلاسیک حمله حاد نقرس است. درسنامه به وضوح اشاره می‌کند که اریتم (قرمزی) در یک حمله حاد نقرس دیده می‌شود.
- **گزینه د (آرتریت واکنشی): نادرست است.** آرتریت واکنشی نیز یک آرتریت التهابی حاد است که می‌تواند باعث قرمزی و تورم مفاصل درگیر شود.

نکته کامل از درسنامه: علائم التهاب حاد مفصلی

در معاینه بالینی، برخی علائم نشان‌دهنده یک فرآیند التهابی حاد در مفصل هستند.

- **اریتم (Erythema) یا قرمزی روی مفاصل:** قرمزی پوست روی یک مفصل، نشان‌دهنده التهاب حاد است.

- **پاتوفیزیولوژی:** در فرآیندهای التهابی، مدیاتورهایی مانند پروستاگلاندین‌ها آزاد می‌شوند که باعث اتساع عروق خونی (Vasodilation) در ناحیه می‌گردند. این امر جریان خون به مفصل را افزایش داده و منجر به گرمی و قرمزی پوست روی آن می‌شود.
- **بیماری‌های مرتبط:** این علامت به طور مشخص در بیماری‌هایی با التهاب شدید و حاد دیده می‌شود، مانند:
 - **نقرس (Gout):** حمله حاد نقرس با تورم و قرمزی شدید مفصل مشخص می‌شود.
 - **آرتریت سپتیک (عفونی):** عفونت مفصل نیز باعث التهاب حاد همراه با قرمزی می‌شود.
 - **آرتریت پسوریاتیک و تب روماتیسمی** نیز می‌توانند با قرمزی مفصل همراه باشند.
- **تفاوت با آرتریت روماتوئید (RA):** آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی **مزمن** است. هرچند مفصل درگیر گرم، متورم و دردناک است، اما مشخصه اصلی آن "ضخیم شدن غشای سینوئیل" (Synovial thickening) است که در لمس حسی "خمیری" یا "اسفنجی" دارد. قرمزی شدید و واضح پوست، برخلاف بیماری‌های حاد فوق، از تظاهرات شایع RA نیست.

سوال ۶ (بر اساس مفاهیم الگوی درگیری مفاصل در جزوه)

سوال: درگیری کدامیک از مفاصل زیر در آرتریت روماتوئید شایع نیست ولی در استئوآرتریت بسیار شایع است؟

- الف) مفاصل متاکارپوفالانژیال (MCP)
- ب) مفاصل اینترفالانژیال پروگزیمال (PIP)
- ج) مچ دست (Wrist)
- د) مفاصل اینترفالانژیال دیستال (DIP)

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (مفاصل متاکارپوفالانژیال - MCP): نادرست است.** این مفاصل از مکان‌های بسیار شایع درگیری در آرتریت روماتوئید هستند، اما در استئوآرتریت کمتر درگیر می‌شوند.
- **گزینه ب (مفاصل اینترفالانژیال پروگزیمال - PIP): نادرست است.** این مفاصل هم در آرتریت روماتوئید و هم در استئوآرتریت (به صورت گره‌های بوشار) می‌توانند درگیر شوند.
- **گزینه ج (مچ دست - Wrist): نادرست است.** مچ دست یکی از مفاصل کلیدی در آرتریت روماتوئید است و در استئوآرتریت کمتر درگیر می‌شود.
- **گزینه د (مفاصل اینترفالانژیال دیستال - DIP): صحیح است.** در برنامه به طور مشخص بیان می‌کند که آرتریت روماتوئید مفاصل DIP (بند آخر انگشتان) را درگیر **نمی‌کند**. در مقابل، درگیری این مفاصل و ایجاد گره‌های هبردن، یکی از شایع‌ترین و مشخص‌ترین الگوهای درگیری در استئوآرتریت است.

نکته کامل از درسنامه: الگوهای درگیری مفصلی در دست

شناخت اینکه کدام بیماری‌ها کدام مفاصل دست را درگیر می‌کنند، برای رسیدن به تشخیص افتراقی بسیار مهم است. تصویر شماتیک در درسنامه این الگوها را به خوبی نشان می‌دهد:

- **مفاصل اینترفالانژیال دیستال (DIP - بند آخر انگشت):**
 - بیماری‌های شایع: استئوآرتریت (OA) (به صورت گره‌های هیردن) و آرتریت پسوریاتیک.
 - نکته بالینی کلیدی: آرتریت روماتوئید (RA) به طور مشخص این مفاصل را درگیر نمی‌کند. این یک "قانون" مهم در روماتولوژی است.
- **مفاصل اینترفالانژیال پروگزیمال (PIP - بند وسط انگشت):**
 - بیماری‌های شایع: استئوآرتریت (OA) (به صورت گره‌های بوشار)، آرتریت روماتوئید (RA)، لوپوس (SLE) و آرتریت پسوریاتیک.
- **مفاصل متاکارپوفالانژیال (MCP - مفصل بین کف دست و انگشت):**
 - بیماری‌های شایع: آرتریت روماتوئید (RA)، نقرس کاذب و هموکروماتوز.
 - نکته بالینی کلیدی: درگیری این مفاصل به نفع آرتریت روماتوئید است.
- **مچ دست (Wrist):**
 - بیماری‌های شایع: آرتریت روماتوئید (RA)، نقرس کاذب، آرتریت ایدیوپاتیک جوانان و سندرم تونل کارپال.

این دسته‌بندی به ما کمک می‌کند تا با دیدن الگوی درگیری مفاصل، لیست تشخیص‌های افتراقی را محدود و دقیق کنیم.

سوال ۷ (از فایل: سوالات_مقدمات_روماتولوژی_بهمن_98_250423 سوال ۳)

سوال: در بیماری که ضایعات پوستی "پاپول‌های گوترون" (Gottron's Papules) دارد، انتظار وجود کدام علامت بالینی زیر بیشتر است؟

- الف) آرتریت تخریبی مفاصل کوچک
- ب) ضعف عضلات پروگزیمال (ضعف در بلند شدن از صندلی و بالا رفتن از پله)
- ج) خشکی شدید چشم و دهان
- د) پدیده رینود همراه با سفتی پوست انگشتان

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (آرتريت تخریبی مفاصل کوچک): نادرست است.** این علامت مشخصه آرتريت روماتوئید است. پاپول‌های گوترون ارتباطی با این بیماری ندارند.
- **گزینه ب (ضعف عضلات پروگزیمال): صحیح است.** پاپول‌های گوترون یک یافته پوستی بسیار اختصاصی (پاتوگنومونیک) برای بیماری **درماتومیوزیت** هستند. درماتومیوزیت یک میوپاتی التهابی است که مشخصه اصلی آن، ضعف عضلات پروگزیمال (عضلات کمر بند شانه‌ای و لگنی) است. بنابراین، وجود پاپول گوترون قویاً مطرح‌کننده وجود ضعف عضلانی پروگزیمال است.
- **گزینه ج (خشکی شدید چشم و دهان): نادرست است.** این علامت، مشخصه اصلی سندرم شوگرن است.
- **گزینه د (پدیده رینود همراه با سفتی پوست انگشتان): نادرست است.** این علائم مشخصه اصلی بیماری اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک) هستند.

نکته کامل از درسنامه: تظاهرات پوستی و عضلانی درماتومیوزیت

درماتومیوزیت یک بیماری از گروه میوپاتی‌های التهابی است که با دو مشخصه اصلی شناخته می‌شود: **ضعف عضلات پروگزیمال** و **تظاهرات پوستی خاص**.

- **ضعف عضلانی:** ضعف به طور قرینه عضلات کمر بند شانه‌ای (برای بالا بردن دست‌ها) و لگنی (برای بالا رفتن از پله، بلند شدن از صندلی) را درگیر می‌کند.
- **تظاهرات پوستی:** پوست به عنوان پنجره‌ای به سوی این بیماری سیستمیک عمل می‌کند و یافته‌های پوستی آن سرنخ‌های تشخیصی بسیار مهمی هستند.
 - **پاپول‌های گوترون (Gottron's papules):** این یافته **پاتوگنومونیک** (بسیار اختصاصی) برای درماتومیوزیت است.
 - **توصیف:** برجستگی‌های کوچک (پاپول) قرمز یا بنفش رنگ که به صورت مجزا بر روی سطوح پشتی مفاصل دست (MCP و IP) و همچنین روی آرنج و زانوها ایجاد می‌شوند.
 - **پاتوفیزیولوژی:** این ضایعات ناشی از ورم و التهاب در لایه درم پوست هستند که با آسیب عروق کوچک زیرین مرتبط است.
 - **اریتم و تلانژکتازی اطراف ناخن (Periungual erythema and telangiectasia):** قرمزی و دیده شدن مویرگ‌های گشاد شده در چین‌های اطراف ناخن که نشان‌دهنده آسیب میکروواسکولار (آسیب عروق بسیار کوچک) است.

سوال ۸ (از فایل: روماتولوژی_اردیبهشت_۱۴۰۲ و سایر فایل‌ها)

سوال: راش پروانه‌ای یا مالار (Malar Rash) که روی گونه‌ها و پل بینی ایجاد شده و خطوط خنده را درگیر نمی‌کند، تظاهر کلاسیک کدام بیماری است؟

- الف) لوپوس پوستی حاد (ACLE)
- ب) اسکلرودرمی
- ج) درماتومیوزیت
- د) لوپوس دیسکوئید (DLE)

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (لوپوس پوستی حاد - ACLE): صحیح است.** درسنامه به وضوح بیان می‌کند که تظاهر کلاسیک لوپوس پوستی حاد، راش مالار یا "پروانه‌ای" است که گونه‌ها و پل بینی را درگیر کرده اما چین‌های نازولببیل (خط خنده) را درگیر نمی‌کند. این فرم به شدت با فعالیت بیماری سیستمیک لوپوس (SLE) در ارتباط است.
- **گزینه ب (اسکلرودرمی): نادرست است.** تظاهرات پوستی صورت در اسکلرودرمی شامل سفت شدن پوست، شیارهای شعاعی اطراف دهان (میکرواستومی) و تلانژکتازی است، نه راش پروانه‌ای.
- **گزینه ج (درماتومیوزیت): نادرست است.** اگرچه درماتومیوزیت راش صورت (راش هلیوتروپ به رنگ بنفش روی پلک‌ها) دارد، اما نمای کلاسیک پروانه‌ای مشخصه آن نیست.
- **گزینه د (لوپوس دیسکوئید - DLE): نادرست است.** لوپوس دیسکوئید فرم مزمن لوپوس پوستی است که ضایعات آن معمولاً باعث ایجاد اسکار و آتروفی (تحلیل رفتن پوست) می‌شوند و با راش حاد پروانه‌ای متفاوت هستند.

نکته کامل از درسنامه: تظاهرات پوستی لوپوس اریتماتوز

ضایعات پوستی از شایع‌ترین یافته‌ها در بیماری لوپوس هستند و به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند.

۱. لوپوس پوستی حاد (Acute Cutaneous Lupus Erythematosus - ACLE):

- **ارتباط بالینی:** این فرم به شدت با فعالیت بیماری لوپوس سیستمیک (SLE) مرتبط است.
- **تظاهر کلاسیک (راش مالار یا راش پروانه‌ای):**
 - **شکل ظاهری:** این راش به صورت اریتم (قرمزی)، که گاهی با ادم (ورم) همراه است، بر روی گونه‌ها و پل بینی ظاهر می‌شود.
 - **ویژگی کلیدی:** یک مشخصه بسیار مهم این است که راش پروانه‌ای، چین‌های نازولببیل (خطوط خنده) را درگیر نمی‌کند (sparing of nasolabial folds).

- **پاتوفیزیولوژی:** این ضایعات نتیجه التهاب ناشی از رسوب کمپلکس‌های ایمنی در محل اتصال درم و اپیدرم پوست است. این فرآیند توسط اشعه ماوراء بنفش خورشید (UV) تشدید می‌شود، به همین دلیل این ضایعات **حساس به نور** (Photosensitive) هستند.

۲. لوپوس پوستی تحت حاد (SCLC):

- ضایعات حساس به نور که معمولاً اسکار به جا نمی‌گذارند و به دو شکل **حلقوی (Annular)** یا **پاپولواسکوموس (شبهه پسوریازیس)** دیده می‌شوند.

۳. لوپوس پوستی مزمن یا دیسکوئید (DLE):

- این فرم معمولاً باعث ایجاد **اسکار و آتروفی (تحلیل رفتن) پوست** می‌شود. ضایعات آن به صورت پلاک‌های قرمز رنگ با حاشیه مشخص هستند.

سوال ۹

سوال: تست شوبر (Schober's Test) برای اندازه‌گیری کمی کدام حرکت در ستون فقرات به کار می‌رود و محدودیت در آن، یکی از معیارهای تشخیصی کدام بیماری است؟

- الف) اکستنشن (صاف شدن به عقب) ستون فقرات گردنی - آرتروز گردن
- ب) فلکشن جانبی (خم شدن به پهلو) ستون فقرات پشتی - اسکولیوز
- ج) فلکشن (خم شدن به جلو) ستون فقرات کمری - اسپوندیلیت انکیلوزان
- د) روتیشن (چرخش) ستون فقرات - دیسک کمر

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف و ب: نادرست است.** تست شوبر مربوط به خم شدن به جلوی ستون فقرات کمری است، نه حرکات گردنی یا پشتی.
- **گزینه ج (فلکشن ستون فقرات کمری - اسپوندیلیت انکیلوزان): صحیح است.** تست شوبر به طور خاص و کمی، میزان خم شدن (فلکشن) ستون فقرات کمری را اندازه‌گیری می‌کند. در بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان، به دلیل التهاب و جوش خوردن مهره‌ها، انعطاف‌پذیری ستون فقرات کمری از بین می‌رود و افزایش فاصله بین دو نقطه مشخص شده در این تست، کمتر از حد طبیعی (کمتر از ۵ سانتی‌متر) خواهد بود. این یافته یکی از معیارهای تشخیصی مهم برای این بیماری است.
- **گزینه د: نادرست است.** این تست میزان فلکشن را اندازه می‌گیرد، نه چرخش.

نکته کامل از درسنامه: تست شوبر (Schober's test)

این تست یک روش معاینه بالینی برای ارزیابی کمی و دقیق میزان انعطاف‌پذیری و حرکت فلکشن (خم شدن به جلو) ستون فقرات کمری است. این تست به خصوص برای تشخیص بیماری‌های گروه اسپوندیلوآرتریت، مانند اسپوندیلیت انکیلوزان، ضروری است.

• روش انجام:

- در حالی که بیمار ایستاده است، نقطه‌ای در خط وسط کمر هم‌سطح با فرورفتگی‌های ونوس (محل مفاصل ساکروایلیاک) مشخص می‌شود.
- یک علامت ۱۰ سانتی‌متر بالاتر از نقطه اول زده می‌شود.
- از بیمار خواسته می‌شود تا کاملاً به جلو خم شود (مانند حالت لمس نوک انگشتان پا).
- فاصله جدید بین دو علامت اندازه‌گیری می‌شود.

• تفسیر نتایج:

- فرد سالم:** در یک فرد سالم، هنگام خم شدن، مهره‌های کمری از هم فاصله گرفته و این فاصله باید حداقل ۵ سانتی‌متر افزایش یابد (یعنی فاصله جدید به بیش از ۱۵ سانتی‌متر برسد).
- بیمار مبتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان:** در این بیماری، به دلیل التهاب و جوش خوردن (فیوژن) مهره‌ها، ستون فقرات کمری انعطاف خود را از دست می‌دهد. در نتیجه، هنگام خم شدن، فاصله بین دو نقطه افزایش نیافته یا افزایش بسیار کمی (کمتر از ۵ سانتی‌متر) خواهد داشت. این یافته یکی از **معیارهای تشخیصی مهم برای اسپوندیلیت انکیلوزان** است.

سوال ۱۰

سوال: کدام تست بالینی برای ارزیابی افیوژن (تجمع مایع) متوسط تا زیاد در مفصل زانو به کار می‌رود؟

- الف) تست شوبر (Schober's test)
- ب) تست فشار متاکارپ (Metacarpal squeeze)
- ج) تست موج یا برجستگی (Bulge test)
- د) تست ضربه کشکک (Patellar tap test)

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (تست شوبر): نادرست است.** این تست برای اندازه‌گیری میزان خم شدن ستون فقرات کمری به کار می‌رود و ارتباطی با معاینه زانو ندارد.
- **گزینه ب (تست فشار متاکارپ): نادرست است.** این تست برای بررسی وجود التهاب در مفاصل کف دست (MCP) استفاده می‌شود.
- **گزینه ج (تست موج یا برجستگی): نادرست است.** اگرچه این تست برای افیوژن زانو است، اما طبق درسنامه، برای تشخیص افیوژن‌های کم به کار می‌رود، نه متوسط تا زیاد.
- **گزینه د (تست ضربه کشکک): صحیح است.** درسنامه به طور مشخص بیان می‌کند که "تست ضربه کشکک" برای ارزیابی افیوژن‌های متوسط تا زیاد در زانو استفاده می‌شود. در این حالت، میزان مایع به قدری است که استخوان کشکک را از روی استخوان ران شناور می‌کند.

نکته کامل از درسنامه: معاینه برای افیوژن زانو (تجمع مایع در مفصل)

افیوژن یا تجمع مایع در مفصل زانو، یکی از یافته‌های مهم در بیماری‌های التهابی یا تروماتیک است. برای تشخیص میزان مایع، از دو تست اصلی استفاده می‌شود:

۱. تست ضربه کشکک (Patellar Tap Test):

- **کاربرد:** برای افیوژن‌های متوسط تا زیاد.
- **روش انجام:**
 ۱. با یک دست، از بالای ران به سمت پایین فشار آورده می‌شود تا مایع از کیسه فوق کشککی (suprapatellar pouch) به فضای پشت کشکک رانده شود.
 ۲. با انگشتان دست دیگر، به آرامی روی استخوان کشکک (پاتلا) به سمت پایین فشار وارد می‌شود (ضربه زده می‌شود).
- **تفسیر:** اگر افیوژن قابل توجهی وجود داشته باشد، کشکک روی مایع شناور است. با فشار دادن، کشکک به استخوان ران در زیر خود برخورد کرده (صدای "tap" می‌دهد) و سپس دوباره به حالت اول باز می‌گردد (بالا می‌آید). این یافته نشان‌دهنده وجود حجم متوسط تا زیاد مایع در مفصل است.

۲. تست موج یا برجستگی (Bulge Test / Massage Test):

- **کاربرد:** برای افیوژن‌های کم.
- **روش انجام:**
 ۱. ابتدا هرگونه مایع از سمت داخلی (مدیال) زانو به سمت بالا دوشیده می‌شود تا آن ناحیه خالی شود.
 ۲. سپس با دست دیگر، سمت خارجی (لترال) زانو به سمت پایین نوازش می‌شود.

- **تفسیر:** این کار باعث می‌شود مقدار کم مایع از سمت خارجی به سمت داخلی که خالی شده است، حرکت کند و یک "موج" یا "برجستگی" (bulge) قابل مشاهده در سمت داخلی زانو ایجاد شود. این تست برای تشخیص مقادیر کم مایع بسیار حساس است.

سوال ۱۱

سوال: کدام یک از یافته‌های پوستی زیر در صورت بیماران مبتلا به اسکروز سیستمیک (اسکلرودرمی) شایع است؟

- الف) راش پروانه‌ای روی گونه‌ها
- ب) راش هلیوتروپ (بنفش رنگ) روی پلک‌ها
- ج) شیارهای شعاعی اطراف دهان و محدودیت در باز کردن دهان
- د) پلاک‌های قرمز با مرکز آتروفیک و اسکار

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (راش پروانه‌ای): نادرست است.** این راش مشخصه لوپوس پوستی حاد است.
- **گزینه ب (راش هلیوتروپ): نادرست است.** این راش بنفش رنگ روی پلک‌ها، علامت کلاسیک درماتومیوزیت است.
- **گزینه ج (شیارهای شعاعی اطراف دهان و محدودیت در باز کردن دهان): صحیح است.** به دلیل فیبروز و سفت شدن پوست صورت در اسکلوئیدرمی، پوست اطراف دهان به داخل کشیده شده و شیارهایی شعاعی (Furrows) ایجاد می‌کند. این حالت همچنین باعث محدودیت در باز کردن دهان (میکرواستومی) می‌شود که از یافته‌های مشخصه این بیماری است.
- **گزینه د (پلاک‌های قرمز با اسکار): نادرست است.** این توصیف بیشتر با ضایعات لوپوس دیسکوئید (فرم مزمن لوپوس پوستی) مطابقت دارد.

نکته کامل از درسنامه: تظاهرات پوستی صورت در اسکروز سیستمیک (اسکلرودرمی)

بیماری اسکروز سیستمیک با فیبروز (سخت و ضخیم شدن) پوست و اعضای داخلی مشخص می‌شود. این تغییرات در پوست صورت، نماهای بالینی بسیار مشخصی ایجاد می‌کنند که سرخ تشخیصی مهمی هستند.

- **شیارهای شعاعی اطراف دهان (Perioral Furrows):**
 - **مکانیسم:** فیبروز و سفت شدن پوست اطراف دهان باعث می‌شود پوست به داخل کشیده شود و شیارها یا چین‌های عمودی و شعاعی ایجاد کند که از لب‌ها به سمت بیرون امتداد دارند.

- **محدودیت باز کردن دهان (میکرواستومی):** همین فرآیند سفت شدن پوست، قابلیت ارتجاعی آن را از بین برده و باعث محدودیت در باز کردن کامل دهان می‌شود.
- **تلانژکتازی (Telangiectasia):**
 - **شکل ظاهری:** دسته‌هایی از مویرگ‌های گشاد شده که به صورت لکه‌های قرمز کوچک روی پوست دیده می‌شوند.
 - **محل شایع:** این ضایعات به خصوص در ناحیه صورت (اطراف دهان)، کف دست‌ها و گردن شایع هستند و ناشی از آسیب و بازآرایی غیرطبیعی عروق کوچک می‌باشند.
- **پوست سفت و کشیده:** به طور کلی پوست صورت حالت سفت، براق و مومی شکل پیدا می‌کند و چین و چروک‌های طبیعی آن از بین می‌رود و ظاهری "ماسک مانند" به چهره می‌دهد.

سوال ۱۲

سوال: ندول‌های روماتوئید که شایع‌ترین تظاهر خارج مفصلی آرتریت روماتوئید هستند، معمولاً در کدام ناحیه دیده می‌شوند؟

- الف) روی سطوح پشتی مفاصل انگشتان دست
- ب) در ناحیه کام سخت دهان
- ج) روی سطوحی که تحت فشار قرار دارند مانند سطح پشتی ساعد نزدیک آرنج
- د) در زیر بستر ناخن‌ها

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (روی سطوح پشتی مفاصل انگشتان دست): نادرست است.** برجستگی روی مفاصل پشتی انگشتان دست بیشتر مشخصه پاپول‌های گوترون (در درماتومیوزیت) یا گره‌های هبردن/بوشار (در استئوآرتریت) است.
- **گزینه ب (در ناحیه کام سخت دهان): نادرست است.** ندول روماتوئید معمولاً در مخاط دهان ایجاد نمی‌شود.
- **گزینه ج (روی سطوحی که تحت فشار قرار دارند مانند سطح پشتی ساعد نزدیک آرنج): صحیح است.** درسنامه به وضوح بیان می‌کند که ندول‌های روماتوئید توده‌های التهابی هستند که "معمولاً روی سطوحی که تحت فشار قرار دارند مانند سطح پشتی ساعد نزدیک آرنج ایجاد می‌شوند". ناحیه اولکرانون آرنج یکی از شایع‌ترین مکان‌ها برای این ندول‌هاست.
- **گزینه د (در زیر بستر ناخن‌ها): نادرست است.** این ناحیه محل شایعی برای ندول روماتوئید نیست.

نکته کامل از درسنامه: ندول روماتوئید (Rheumatoid Nodule)

ندول روماتوئید شایع‌ترین تظاهر خارج مفصلی بیماری آرتریت روماتوئید (RA) است و معمولاً در بیمارانی دیده می‌شود که فاکتور روماتوئید (RF) آنها مثبت است.

- **ماهیت:** این ندول‌ها توده‌های التهابی از نوع گرانولوماتوز هستند که در زیر پوست تشکیل می‌شوند. آنها معمولاً سفت بوده و به ساختارهای زیرین چسبیده‌اند.
- **مکانیسم پاتوفیزیولوژی:** از نظر بافت‌شناسی، ندول روماتوئید دارای یک مرکز **نکروز فیبرینوئید** است که توسط سلول‌های ایمنی مانند ماکروفاژها و فیبروبلاست‌ها احاطه شده است.
- **محل شایع:** این ندول‌ها به طور مشخص در نواحی از بدن که تحت **فشار یا ترومای مکرر** قرار می‌گیرند، ایجاد می‌شوند. شایع‌ترین محل‌ها عبارتند از:
 - **سطح اکستانسور (پشتی) ساعد، نزدیک به مفصل آرنج.**
 - **روی زائده اولکرانون آرنج.**
 - نقاط تحت فشار دیگر مانند تاندون آشیل یا نواحی از پا که در تماس با کفش هستند.
- **اهمیت بالینی:** وجود ندول روماتوئید معمولاً نشان‌دهنده یک فرم شدیدتر از بیماری آرتریت روماتوئید است.

سوال ۱۳

سوال: محدودیت در کدام حرکت مفصل ران، اغلب به عنوان اولین و حساس‌ترین علامت بالینی استئوآرتریت (آرتروز) آن مفصل در نظر گرفته می‌شود؟

- الف) فلکشن (خم کردن ران به سمت سینه)
- ب) ابداکشن (دور کردن پا از بدن)
- ج) روتیشن خارجی (چرخش خارجی)
- د) روتیشن داخلی (چرخش داخلی)

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف و ب: نادرست است.** اگرچه در مراحل پیشرفته آرتروز هیپ، حرکات فلکشن و ابداکشن نیز محدود می‌شوند، اما اینها اولین و حساس‌ترین علامت بیماری نیستند.
- **گزینه ج (روتیشن خارجی): نادرست است.** معمولاً دامنه حرکتی چرخش خارجی برای مدت طولانی‌تری نسبت به چرخش داخلی حفظ می‌شود.

- **گزینه د (روتیشن داخلی): صحیح است.** درسنامه به طور مشخص و به عنوان یک نکته بالینی مهم بیان می‌کند که: "محدودیت در چرخش داخلی (Internal Rotation) اغلب اولین و حساسترین علامت استئوآرتریت (آرتروز) مفصل ران است."

نکته کامل از درسنامه: معاینه حرکات مفصل ران (Hip Examination)

ارزیابی دامنه حرکتی مفصل ران بخش مهمی از معاینه فیزیکی است. حرکات اصلی این مفصل شامل فلکشن، اکستنشن، اداکشن، اداکشن، روتیشن داخلی و روتیشن خارجی است.

- **روش معاینه روتیشن داخلی (Internal Rotation):**
 1. بیمار به پشت می‌خوابد (وضعیت supine).
 2. ران و زانوی بیمار تا زاویه ۹۰ درجه خم می‌شود.
 3. معاینه‌کننده در حالی که ران را ثابت نگه داشته، ساق پای بیمار را به سمت **خارج** (lateral) حرکت می‌دهد.
 4. این حرکت ساق پا به سمت خارج، باعث **چرخش داخلی** سر استخوان ران در داخل حفره استابولوم می‌شود.
- **اهمیت بالینی:** از بین تمام حرکات مفصل ران، محدودیت در **چرخش داخلی** از اهمیت تشخیصی ویژه‌ای برخوردار است. این یافته اغلب **اولین و حساس‌ترین علامت بالینی** است که در استئوآرتریت (آرتروز) مفصل ران ظاهر می‌شود. بنابراین، هنگام شک به بیماری‌های مفصل ران، ارزیابی دقیق این حرکت هرگز نباید فراموش شود.

سوال ۱۴

سوال: تغییرات ناخن مانند "pitting" (وجود حفره‌های ریز و سوزنی) یکی از یافته‌های مهم و مشخصه کدام بیماری روماتولوژیک است؟

- الف) لوپوس اریتماتوز سیستمیک
- ب) آرتریت پسوریاتیک
- ج) اسکلوئودرمی
- د) استئوآرتریت

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (لوپوس): نادرست است.** اگرچه در لوپوس تظاهرات پوستی و ریزش مو شایع است، اما pitting ناخن مشخصه آن نیست.

- **گزینه ب (آرتریت پسوریاتیک): صحیح است.** درسنامه به طور مستقیم اشاره می‌کند که "تغییرات ناخن مانند pitting در آرتریت پسوریاتیک... بسیار مهم هستند." این یافته یکی از سرنخ‌های کلیدی برای تشخیص این بیماری است.
- **گزینه ج (اسکلرودرمی): نادرست است.** تغییرات ناخن در اسکلرودرمی بیشتر شامل زخم‌های نوک انگشت و تغییرات ناشی از کاهش خون‌رسانی (ایسکمی) است.
- **گزینه د (استئوآرتریت): نادرست است.** مشخصه استئوآرتریت در دست، ایجاد گره‌های استخوانی هبردن و بوشار است، نه تغییرات خود ناخن.

نکته کامل از درسنامه: اهمیت معاینه ناخن و مو در روماتولوژی

معاینه ساختارهای ضمیمه پوست مانند ناخن و مو می‌تواند سرنخ‌های تشخیصی بسیار ارزشمندی در بیماری‌های روماتولوژیک ارائه دهد.

- **معاینه ناخن (Nail Examination):** تغییرات خاص در ناخن‌ها قویاً مطرح‌کننده بیماری‌های زمینه‌ای خاصی هستند.
 - **Pitting (حفره‌های سوزنی):** وجود حفره‌های ریز و متعدد روی سطح صفحه ناخن. این علامت یکی از یافته‌های کلاسیک و بسیار مهم در آرتریت پسوریاتیک (Psoriatic Arthritis) است.
 - **Onycholysis (جدا شدن ناخن از بستر):** این حالت نیز می‌تواند در آرتریت پسوریاتیک دیده شود.
 - **ضخیم شدن ناخن:** از دیگر تغییرات ناخن در آرتریت پسوریاتیک است.
- **معاینه مو (Hair Examination):**
 - **ریزش مو (Alopecia):** ریزش موی منتشر یا تکه‌ای می‌تواند یکی از تظاهرات مهم بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) باشد.

بنابراین، مشاهده دقیق ناخن‌ها و پرسش در مورد ریزش مو، بخش جدایی‌ناپذیر یک معاینه کامل روماتولوژی است.

سوال ۱۵

سوال: کدام یک از تعاریف زیر در مورد حرکات مفصلی صحیح است؟

- الف) Abduction به معنای نزدیک کردن یک اندام به خط وسط بدن است.
- ب) Flexion به معنای صاف کردن یا افزایش زاویه بین دو استخوان است.
- ج) Pronation به معنای چرخاندن ساعد به طوری که کف دست به سمت پایین قرار گیرد.
- د) Eversion به معنای چرخاندن کف پا به سمت داخل است.

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (Abduction): نادرست است.** Abduction به معنای **دور کردن** یک اندام از خط وسط بدن است. نزدیک کردن اندام Adduction نام دارد.
- **گزینه ب (Flexion): نادرست است.** Flexion (فلکشن) به معنای **خم کردن** یا کاهش زاویه بین دو استخوان است. صاف کردن Extension نام دارد.
- **گزینه ج (Pronation): صحیح است.** Pronation (پروناسیون) دقیقاً به معنای چرخاندن ساعد است به طوری که کف دست رو به پایین قرار گیرد. حرکت معکوس آن Supination (سوپیناسیون) است که کف دست رو به بالا قرار می‌گیرد (حالت دعا یا گدایی).
- **گزینه د (Eversion): نادرست است.** Eversion به معنای چرخاندن کف پا به سمت **خارج** است. چرخاندن کف پا به سمت داخل Inversion نامیده می‌شود.

نکته کامل از درسنامه: اصطلاحات حرکتی (Terminology)

برای توصیف دقیق یافته‌های معاینات مفصلی، استفاده از زبان مشترک و استاندارد ضروری است. مهم‌ترین اصطلاحات حرکتی عبارتند از:

- **Flexion (فلکشن):** خم کردن یا **کاهش زاویه** بین دو استخوان در یک مفصل.
- **Extension (اکستنشن):** صاف کردن یا **افزایش زاویه** بین دو استخوان.
- **Hyperextension (هایپراکستنشن):** ادامه حرکت Extension بیش از وضعیت صاف یا آناتومیک.
- **Abduction (ابداکشن):** **دور کردن** یک اندام از خط وسط بدن.
- **Adduction (ادداکشن):** **نزدیک کردن** یک اندام به خط وسط بدن.
- **Internal Rotation (روتیشن داخلی):** چرخاندن اندام به سمت **داخل** حول محور طولی آن.
- **External Rotation (روتیشن خارجی):** چرخاندن اندام به سمت **خارج** حول محور طولی آن.
- **Pronation (پروناسیون):** چرخاندن ساعد به طوری که کف دست به سمت **پایین** قرار گیرد.
- **Supination (سوپیناسیون):** چرخاندن ساعد به طوری که کف دست به سمت **بالا** قرار گیرد.
- **Inversion (اینورژن):** چرخاندن کف پا به سمت **داخل**.
- **Eversion (اورژن):** چرخاندن کف پا به سمت **خارج**.
- **Dorsiflexion (دورسی فلکشن):** حرکت مچ پا به سمت **بالا** (نزدیک کردن پشت پا به ساق).
- **Plantar flexion (پلانتار فلکشن):** حرکت مچ پا به سمت **پایین** (مانند فشار دادن پدال گاز).

سوال ۱۶

سوال: کدام یک از تغییرات وضعیتی زیر، نمای کلاسیک مراحل پیشرفته بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان (Ankylosing Spondylitis) است؟

- الف) لوردوز کمری شدید (قوس زیاد کمر)
- ب) صافی کامل ستون فقرات بدون هیچ قوسی
- ج) کیفوز پشتی ثابت و شدید (گوزپشتی)
- د) اسکولیوز شدید (انحراف جانبی ستون فقرات)

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (لوردوز کمری شدید): نادرست است.** در اسپوندیلیت انکیلوزان، قوس طبیعی کمر (لوردوز) اغلب از بین رفته و کمر صاف می‌شود، نه اینکه قوس آن تشدید شود.
- **گزینه ب (صافی کامل ستون فقرات): نادرست است.** اگرچه ستون فقرات کمری تمایل به صاف شدن دارد، اما ستون فقرات پشتی (توراسیک) دچار یک انحنای شدید به سمت جلو (کیفوز) می‌شود.
- **گزینه ج (کیفوز پشتی ثابت و شدید): صحیح است.** درسنامه به وضوح اشاره می‌کند که در مراحل پیشرفته اسپوندیلیت انکیلوزان، به دلیل التهاب مزمن و جوش خوردن مهره‌ها، انعطاف‌پذیری ستون فقرات از بین رفته و یک "کیفوز پشتی ثابت و شدید" ایجاد می‌شود. این حالت گوزپشتی، نمای کلاسیک بیماری پیشرفته است.
- **گزینه د (اسکولیوز شدید): نادرست است.** اسکولیوز به انحراف جانبی (به پهلو) ستون فقرات گفته می‌شود و تغییر شکل مشخصه اسپوندیلیت انکیلوزان نیست.

نکته کامل از درسنامه: معاینه ستون فقرات و تغییرات وضعیتی در اسپوندیلیت انکیلوزان (AS)

معاینه وضعیتی بدن (Posture) در حالت ایستاده، بخش مهمی از ارزیابی بیماران روماتولوژی است.

• تعاریف:

1. **کیفوز (Kyphosis):** افزایش غیرطبیعی قوس پشتی ستون فقرات توراسیک که به آن "گوزپشتی" می‌گویند.
 2. **لوردوز (Lordosis):** افزایش قوس کمری ستون فقرات لومبار.
- **پاتوفیزیولوژی در اسپوندیلیت انکیلوزان:** این بیماری یک بیماری التهابی مزمن است که مفاصل ستون فقرات و لیگامان‌ها را درگیر می‌کند. این التهاب در نهایت منجر به **استخوانی شدن و جوش خوردن (فیوژن)** مهره‌ها به یکدیگر می‌شود.
 - **تغییرات وضعیتی ناشی از بیماری:**
 1. **از بین رفتن انعطاف‌پذیری:** ستون فقرات خشک و غیرقابل انعطاف می‌شود.
 2. **صاف شدن کمر:** قوس طبیعی ستون فقرات کمری (لوردوز) از بین می‌رود.

3. **ایجاد کیفوز پستی:** مهم‌ترین تغییر، ایجاد یک **کیفوز پستی ثابت و شدید** است. این تغییرات مجموعاً باعث ایجاد یک وضعیت بدنی خمیده به جلو می‌شود که در آن بیمار قادر به صاف ایستادن نیست. این نما، کلاسیک مراحل پیشرفته اسپوندیلیت انکیلوزان است.

سوال ۱۷

سوال: اندازه‌گیری انبساط قفسه سینه برای تشخیص کدام بیماری اهمیت کلیدی دارد و محدودیت در آن (کمتر از ۴ سانتی‌متر) نشان‌دهنده چیست؟

- الف) آرتريت روماتوئيد - نشان‌دهنده ضعف عضلات بين دنده‌ای است.
 - ب) اسکرودرمی - نشان‌دهنده فیبروز پوست قفسه سینه است.
 - ج) اسپوندیلیت انکیلوزان - نشان‌دهنده التهاب و جوش خوردن مفاصل دنده‌ها به مهره‌ها است.
 - د) لوپوس - نشان‌دهنده درگیری پرده جنب (پلورزی) است.
-

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف، ب و د: نادرست است.** اگرچه این بیماری‌ها می‌توانند سیستم تنفسی را درگیر کنند، اما تست اندازه‌گیری انبساط قفسه سینه به طور اختصاصی برای غربالگری و تشخیص **اسپوندیلیت انکیلوزان** به کار می‌رود.
 - **گزینه ج (اسپوندیلیت انکیلوزان - نشان‌دهنده التهاب و جوش خوردن مفاصل دنده‌ها به مهره‌ها است): صحیح است.** این تست برای تشخیص اسپوندیلیت انکیلوزان بسیار مهم است. در این بیماری، التهاب و جوش خوردن (فیوژن) مفاصل کوستوورترال (محل اتصال دنده‌ها به مهره‌های پشتی) باعث کاهش شدید تحرک قفسه سینه می‌شود. انبساط قفسه سینه کمتر از ۴ سانتی‌متر غیرطبیعی تلقی شده و قویاً به نفع این بیماری است.
-

نکته کامل از درسنامه: اندازه‌گیری انبساط قفسه سینه (Chest Expansion Measurement)

این تست بخش مهمی از معاینه ستون فقرات پشتی (توراسیک) است و کاربرد اصلی آن در تشخیص اسپوندیلیت انکیلوزان است.

- **اهمیت بالینی:** این تست برای تشخیص **اسپوندیلیت انکیلوزان** بسیار مهم و کلیدی است.
- **روش انجام:**
 - یک متر نواری در سطح نوک سینه‌ها (نیپل) دور قفسه سینه بیمار قرار داده می‌شود.

- از بیمار خواسته می‌شود یک دم بسیار عمیق (maximal inspiration) و سپس یک بازدم کامل (maximal expiration) انجام دهد.
- تفاوت بین اندازه دور قفسه سینه در این دو حالت، میزان انبساط قفسه سینه است.
- **پاتوفیزیولوژی در اسپوندیلیت انکیلوزان:** در این بیماری، مفاصل **کوستوورتربرال** (محل اتصال دنده‌ها به مهره‌های پشتی) دچار التهاب شده و به تدریج جوش می‌خورند (ankylosis). این فرآیند باعث می‌شود قفسه سینه نتواند به خوبی در حین دم باز شود و تحرک آن به شدت کاهش می‌یابد.
- **تفسیر نتایج:**
 - در حالت طبیعی، انبساط قفسه سینه باید **۴ سانتی‌متر یا بیشتر** باشد.
 - انبساط قفسه سینه **کمتر از ۴ سانتی‌متر** غیرطبیعی تلقی می‌شود و یک یافته مهم به نفع اسپوندیلیت انکیلوزان است.

سوال ۱۸

سوال: کریپتوس (Crepitus) که به صورت حس سایش یا "خرخر" در حین حرکت مفصل زانو لمس می‌شود، ناشی از چیست و یکی از علائم کلیدی کدام بیماری است؟

- الف) تجمع کریستال‌های اورات - نقرس
- ب) ضخیم شدن غشای سینوویال - آرتریت روماتوئید
- ج) ساییده شدن سطوح غضروفی نامنظم و آسیب‌دیده - استئوآرتریت
- د) تجمع مایع (افیوژن) در مفصل - سینوویت ویروسی

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (تجمع کریستال‌های اورات - نقرس): نادرست است.** نقرس باعث التهاب حاد می‌شود، اما حس سایش مزمن مشخصه آن نیست.
- **گزینه ب (ضخیم شدن غشای سینوویال - آرتریت روماتوئید): نادرست است.** ضخیم شدن سینوویوم در آرتریت روماتوئید حسی "خمیری" یا "اسفنجی" ایجاد می‌کند، نه حس سایش استخوانی.
- **گزینه ج (ساییده شدن سطوح غضروفی نامنظم و آسیب‌دیده - استئوآرتریت): صحیح است.** در سنانه به وضوح مکانیسم کریپتوس را اینگونه توضیح می‌دهد: "این حس سایش یا خرخر ناشی از ساییده شدن سطوح غضروفی نامنظم و آسیب‌دیده بر روی یکدیگر است و یکی از علائم کلیدی استئوآرتریت محسوب می‌شود."
- **گزینه د (تجمع مایع (افیوژن) در مفصل): نادرست است.** تجمع مایع باعث تورم و احساس شناور بودن کشکک (در تست Patellar tap) می‌شود، نه کریپتوس.

نکته کامل از درسنامه: معاینه زانو و علامت کریپیتوس (Crepitus)

در بخش معاینه حرکات زانو، لمس مفصل حین حرکت برای یافتن کریپیتوس اهمیت دارد.

- **روش بررسی:** از بیمار خواسته می‌شود زانوی خود را خم و صاف کند (فلکشن و اکستنشن). در حین این حرکت، معاینه‌کننده یک دست خود را روی کشکک بیمار قرار می‌دهد تا وجود کریپیتوس را حس کند.
- **تعریف کریپیتوس:** حسی شبیه به سایش، "قرچ قرچ" یا "خرخر" که در حین حرکت مفصل لمس یا شنیده می‌شود.
- **مکانیسم پاتوفیزیولوژی:**
 - در حالت طبیعی، سطوح غضروفی مفاصل کاملاً صاف و لغزنده هستند.
 - در استئوآرتریت (آرتروز)، غضروف مفصلی تخریب شده و سطح آن نامنظم و فرسوده می‌شود.
 - کریپیتوس ناشی از ساییده شدن این سطوح غضروفی ناهموار و آسیب‌دیده بر روی یکدیگر در حین حرکت مفصل است.
- **اهمیت بالینی:** وجود کریپیتوس یکی از علائم کلیدی و بسیار شایع استئوآرتریت است و به تشخیص بالینی این بیماری کمک شایانی می‌کند.

سوال ۱۹

سوال: انجام تست فشار متاتارس‌ها (Metatarsal squeeze test) که با ایجاد درد همراه است، یک یافته حساس برای وجود التهاب در کدام قسمت پا و در تشخیص زودهنگام کدام بیماری‌ها ارزشمند است؟

- الف) پاشنه پا (Hindfoot) - فاسیای کف پا
- ب) مچ پا (Ankle) - نقرس
- ج) جلوی پا (Forefoot) - آرتريت روماتوئید و آرتريت پسوریاتیک
- د) پای میانی (Midfoot) - استئوآرتریت

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف، ب و د: نادرست است.** این تست به طور اختصاصی مفاصل متاتارسوفالانژیال (MTP) را که در جلوی پا (Forefoot) قرار دارند، ارزیابی می‌کند و برای تشخیص التهاب در این ناحیه به کار می‌رود.
- **گزینه ج (جلوی پا - آرتريت روماتوئید و آرتريت پسوریاتیک): صحیح است.** درسنامه به وضوح بیان می‌کند که این تست مفاصل MTP در جلوی پا را تحت فشار قرار می‌دهد و مثبت شدن آن (ایجاد درد) یک یافته بسیار حساس برای وجود التهاب

(سینوویت) است. همچنین ذکر می‌کند که این تست در تشخیص زودهنگام بیماری‌هایی مانند **آرتریت روماتوئید و آرتریت پسوریاتیک** ارزش بالایی دارد.

نکته کامل از درسنامه: معاینه پا و تست فشار متاتارس‌ها (Metatarsal Squeeze Test)

در کنار معاینه دست، معاینه پا نیز در تشخیص بیماری‌های التهابی مفاصل اهمیت زیادی دارد. یکی از تست‌های کلیدی در این معاینه، تست فشار متاتارس‌ها است.

- **آناتومی پا:** پا به سه بخش تقسیم می‌شود: پای جلویی (Forefoot) شامل انگشتان و استخوان‌های متاتارس، پای میانی (Midfoot) و پای عقبی (Hindfoot) شامل پاشنه.
- **تست فشار متاتارس‌ها:**
 - **هدف:** تشخیص وجود التهاب (سینوویت) در مفاصل متاتارسوفالانژیال (MTP) که در جلوی پا قرار دارند.
 - **روش انجام:** همانند تست مشابه در دست، معاینه‌کننده جلوی پای بیمار را گرفته و سرهای استخوان‌های متاتارس را به آرامی از دو طرف به یکدیگر فشار می‌دهد.
 - **تفسیر و اهمیت بالینی:**
 - اگر این مانور باعث ایجاد درد در مفاصل MTP شود، تست **مثبت** تلقی می‌شود.
 - مثبت شدن تست یک یافته **بسیار حساس** برای وجود سینوویت در جلوی پا است.
 - این تست ارزش بالایی در **تشخیص زودهنگام آرتریت‌های التهابی مانند آرتریت روماتوئید و آرتریت پسوریاتیک** دارد، زیرا این بیماری‌ها اغلب در مراحل اولیه مفاصل کوچک پا را درگیر می‌کنند.

سوال ۲۰

سوال: رسوب غیرطبیعی نمک‌های کلسیم در پوست و بافت‌های زیرپوستی که به صورت توده‌های سفت لمس شده و گاهی با خروج ماده گچی همراه است، چه نام دارد و در کدام بیماری‌های روماتولوژیک دیده می‌شود؟

- الف) توفوس (Tophus) - نفرس
- ب) ندول روماتوئید (Rheumatoid Nodule) - آرتریت روماتوئید
- ج) کلسینوزیس کوتیس (Calcinosis Cutis) - اسکرودرمی و درماتومیوزیت
- د) استئوفیت (Osteophyte) - استئوآرتریت

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (توفوس): نادرست است.** توفوس توده‌های ناشی از رسوب کریستال‌های اسید اوریک است که در بیماری نقرس دیده می‌شود.
- **گزینه ب (ندول روماتوئید): نادرست است.** این یک توده التهابی گرانولوماتوز است که در آرتریت روماتوئید یافت می‌شود و ماهیت آن رسوب کلسیم نیست.
- **گزینه ج (کلسینوزیس کوتیس): صحیح است.** این تعریف دقیقاً با توصیف "کلسینوزیس کوتیس" در درسنامه مطابقت دارد. درسنامه نیز به طور مشخص ذکر می‌کند که این پدیده در بیماری‌هایی مانند **اسکلرودرمی و درماتومیوزیت** دیده می‌شود.
- **گزینه د (استئوفیت): نادرست است.** استئوفیت‌ها خارهای استخوانی هستند که در لبه مفاصل مبتلا به آرتروز رشد می‌کنند و بخشی از خود استخوان هستند.

نکته کامل از درسنامه: کلسینوزیس کوتیس (Calcinosis Cutis)

کلسینوزیس کوتیس یکی از تظاهرات پوستی مهم در برخی بیماری‌های بافت همبند است.

- **تعریف:** رسوب غیرطبیعی نمک‌های کلسیم (عمدتاً هیدروکسی آپاتیت کلسیم) در پوست و بافت‌های زیرپوستی.
- **تظاهر بالینی:**
 - این رسوبات به صورت **توده‌ها یا ندول‌های سفت و نامنظم** در زیر پوست لمس می‌شوند.
 - گاهی اوقات این رسوبات به سطح پوست راه پیدا کرده و باعث خروج یک **ماده سفیدرنگ، گچی یا خمیری** می‌شوند.
 - این ضایعات می‌توانند دردناک باشند، به خصوص اگر روی مفاصل یا نوک انگشتان قرار گیرند.
- **پاتوفیزیولوژی:** مکانیسم دقیق آن ناشناخته است، اما به نظر می‌رسد که التهاب و آسیب بافتی مزمن، محیطی را فراهم می‌کند که منجر به رسوب کلسیم می‌شود.
- **بیماری‌های مرتبط:** کلسینوزیس کوتیس به طور مشخص در بیماری‌های التهابی مانند موارد زیر دیده می‌شود:
 - **اسکلروز سیستمیک (اسکلرودرمی)**
 - **درماتومیوزیت**

سوال ۲۱

سوال: در بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان، کدام یافته رادیوگرافیک زیر دیده **نمی‌شود** و مشخصه بیماری دیگری به نام DISH است؟

- الف) درخشان شدن گوشه قدامی مهره (Shiny corner sign)
- ب) نمای موم روان (Flowing wax) در قسمت قدامی جسم مهره

- (ج) مربعی شدن مهره‌ها (Squaring)
- (د) ایجاد سین‌دسموفیت (Syndesmophyte)

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف، ج و د: نادرست است.** این سه مورد (درخشان شدن گوشه مهره، مربعی شدن مهره‌ها، و سین‌دسموفیت) همگی از تظاهرات رادیوگرافیک کلاسیک و مشخصه بیماری **اسپوندیلیت انکیلوزان** هستند.
- **گزینه ب (نمای موم روان): صحیح است.** در فایل نمونه سوالات به طور مشخص اشاره شده است که نمای "موم روان" یا "Flowing wax" مربوط به بیماری (DISH) (Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis) است و از تشخیص‌های افتراقی اسپوندیلیت انکیلوزان محسوب می‌شود، نه یکی از یافته‌های خود آن.

نکته کامل از درسنامه (بر اساس اطلاعات تکمیلی از فایل سوالات):

در بررسی رادیوگرافیک بیماران مشکوک به اسپوندیلیت انکیلوزان (AS)، شناخت یافته‌های مشخصه این بیماری و افتراق آن‌ها از سایر بیماری‌ها اهمیت دارد.

- **یافته‌های رادیوگرافیک مشخصه اسپوندیلیت انکیلوزان (AS):**
 - **ساکروایلایت:** التهاب و در نهایت جوش خوردن مفاصل ساکروایلایک (یافته کلیدی).
 - **درخشان شدن گوشه قدامی مهره (Shiny Corner Sign/Romanus Lesion):** واکنش استخوانی در محل التهاب لبه‌های جسم مهره.
 - **مربعی شدن مهره‌ها (Squaring):** از بین رفتن تقعر طبیعی سطح جلویی جسم مهره به دلیل اروژن و استخوان‌سازی.
 - **سین‌دسموفیت (Syndesmophyte):** پل‌های استخوانی ظریفی که به صورت عمودی بین مهره‌ها ایجاد شده و در نهایت منجر به نمای "ستون خیزران" (Bamboo Spine) می‌شوند.
- **تشخیص افتراقی مهم:**
 - **بیماری (DISH) (Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis):** این بیماری نیز باعث استخوان‌سازی در ستون فقرات می‌شود اما الگوی آن متفاوت است.
 - **نمای موم روان (Flowing Wax Appearance):** مشخصه رادیوگرافیک بیماری DISH، وجود استخوان‌سازی‌های ضخیم و موج‌دار در قسمت قدامی (جلویی) اجسام مهره است که شبیه به موم شمع روان شده به نظر می‌رسد. این نما در اسپوندیلیت انکیلوزان دیده نمی‌شود.

سوال 22

سوال: در معاینه آرنج، سه لندمارک استخوانی اپی‌کندیل داخلی، اپی‌کندیل خارجی و زائده اولکرانون در حالت آرنج خم شده (فلکشن ۹۰ درجه) چه شکلی را تشکیل می‌دهند و به هم خوردن این ارتباط آناتومیک نشان‌دهنده چیست؟

- الف) یک خط مستقیم - آرتروز
- ب) یک مثلث متساوی‌الاضلاع - بورسیت
- ج) یک مثلث متساوی‌الساقین - دررفتگی یا شکستگی
- د) یک مربع - آرنج تنیس‌بازان

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (یک خط مستقیم - آرتروز): نادرست است.** این سه لندمارک در حالت آرنج صاف (اکستنشن) در یک خط مستقیم قرار می‌گیرند، نه در حالت خم شده.
- **گزینه ب (یک مثلث متساوی‌الاضلاع - بورسیت): نادرست است.** درسنامه به طور مشخص به تشکیل مثلث متساوی‌الساقین اشاره می‌کند، نه متساوی‌الاضلاع.
- **گزینه ج (یک مثلث متساوی‌الساقین - دررفتگی یا شکستگی): صحیح است.** طبق درسنامه، در حالت فلکشن ۹۰ درجه آرنج، این سه نقطه یک مثلث متساوی‌الساقین را تشکیل می‌دهند. به هم خوردن این ارتباط آناتومیک می‌تواند نشان‌دهنده یک مشکل ساختاری جدی مانند دررفتگی یا شکستگی باشد.
- **گزینه د (یک مربع - آرنج تنیس‌بازان): نادرست است.** این لندمارک‌ها شکل مربع تشکیل نمی‌دهند.

نکته کامل از درسنامه: معاینه آرنج و اهمیت لندمارک‌های استخوانی

در مرحله لمس (Palpation) معاینه آرنج، بررسی ارتباط بین سه لندمارک استخوانی کلیدی، اهمیت تشخیصی بالایی دارد. این سه لندمارک عبارتند از:

1. اپی‌کندیل داخلی
2. اپی‌کندیل خارجی
3. زائده اولکرانون

• ارتباط آناتومیک طبیعی:

- در حالت آرنج خم (فلکشن ۹۰ درجه): این سه نقطه یک مثلث متساوی‌الساقین تشکیل می‌دهند.
- در حالت آرنج صاف (اکستنشن): این سه نقطه در یک خط مستقیم قرار می‌گیرند.

- **اهمیت بالینی:** این ارتباط فضایی یک راهنمای سریع و مهم برای ارزیابی یکپارچگی ساختاری مفصل آرنج است. اگر این ارتباط به هم خورده باشد (یعنی مثلث یا خط مستقیم مورد انتظار تشکیل نشود)، باید به شدت به وجود یک آسیب جدی مانند **دررفتگی (Dislocation) یا شکستگی (Fracture)** شک کرد. این بررسی به افتراق آسیب‌های بافت نرم (مانند کشیدگی لیگامان) از آسیب‌های استخوانی کمک می‌کند.

سوال 23

سوال: کدام تست عملکردی ترکیبی شانه، حرکات اکستنشن، اداکشن و روتیشن داخلی کامل را ارزیابی می‌کند؟

- الف) گذاشتن هر دو دست پشت سر با آرنج‌های رو به بیرون
- ب) تست خراش اپلی (Apley's Scratch Test) - رساندن دست به پشت کمر
- ج) اداکشن کامل بازو به بالای سر
- د) فلکسیون بازو در برابر مقاومت

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (گذاشتن هر دو دست پشت سر): نادرست است.** این حرکت ترکیبی از فلکشن، اداکشن و روتیشن خارجی است، نه داخلی.
- **گزینه ب (تست خراش اپلی - رساندن دست به پشت کمر): صحیح است.** درسنامه به وضوح بیان می‌کند که حرکت "پایین آوردن بازوها و رساندن دست به پشت کمر مانند خاراندن پشت" که بخشی از تست خراش اپلی است، ترکیبی از اکستنشن، اداکشن و روتیشن داخلی کامل را ارزیابی می‌کند.
- **گزینه ج و د: نادرست است.** اینها حرکات ساده در یک جهت هستند، نه تست‌های عملکردی ترکیبی که در سوال به آن اشاره شده است.

نکته کامل از درسنامه: تست‌های عملکردی ترکیبی برای معاینه شانه

علاوه بر ارزیابی حرکات اصلی شانه در یک جهت (مانند فلکشن، اداکشن و...)، از تست‌های عملکردی ترکیبی برای ارزیابی سریع و کلی عملکرد مفصل شانه استفاده می‌شود. این تست‌ها چندین حرکت را به صورت همزمان می‌سنجند.

- **تست ۱: ارزیابی فلکشن، اداکشن و روتیشن خارجی**
 - **روش انجام:** از بیمار خواسته می‌شود هر دو دست خود را پشت سرش بگذارد، طوری که آرنج‌ها رو به بیرون باشند.

○ **حرکات مورد ارزیابی:** این مانور به طور همزمان نیازمند فلکشن، ابداکشن و روتیشن خارجی مناسب در مفصل شانه است.

• **تست ۲: ارزیابی اکستنشن، اداکشن و روتیشن داخلی (بخشی از تست خراش اپلی - Apley's Scratch Test)**

- **روش انجام:** از بیمار خواسته می‌شود بازوی خود را پایین آورده و دستش را از پشت به کمر برساند و سعی کند تا جای ممکن به سمت بالا (مثلاً برای خاراندن بین دو کتف) حرکت دهد.
- **حرکات مورد ارزیابی:** این مانور نیازمند اکستنشن، اداکشن و روتیشن داخلی کامل است. محدودیت در این حرکت می‌تواند نشان‌دهنده مشکلاتی مانند کپسولیت چسبنده (شانه یخ‌زده) یا مشکلات تاندون‌های روتاتور کاف باشد.

سوال 24

سوال: کدام یک از یافته‌های زیر که در لمس حس "خمیری" یا "اسفنجی" بودن کپسول مفصلی را می‌دهد، مشخصه اصلی آرتریت‌های التهابی مانند آرتریت روماتوئید است؟

- الف) افزایش گرما (Increased warmth)
- ب) حساسیت در لمس (Tenderness)
- ج) ضخیم شدن غشای سینوئیل (Synovial thickening)
- د) کریپتوس (Crepitus)

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف و ب: نادرست است.** اگرچه افزایش گرما و حساسیت به لمس از علائم التهاب هستند، اما مشخصه اصلی و پاتوگنومونیک آرتریت روماتوئید نیستند و در بسیاری از انواع آرتریت دیده می‌شوند.
- **گزینه ج (ضخیم شدن غشای سینوئیل): صحیح است.** درسنامه به طور مشخص بیان می‌کند که "ضخیم شدن غشای سینوئیل (Synovial thickening)" با احساس "خمیری یا اسفنجی بودن کپسول مفصلی هنگام لمس" مشخص می‌شود. این حالت که به آن **سینوویت (Synovitis)** گفته می‌شود، "مشخصه اصلی آرتریت‌های التهابی مانند آرتریت روماتوئید است."
- **گزینه د (کریپتوس): نادرست است.** کریپتوس حس سایش است و مشخصه استئوآرتریت (آرتروز) است، نه آرتریت روماتوئید.

نکته کامل از درسنامه: لمس مفصل در آرتریت‌های التهابی

در مرحله لمس (Palpation) معاینه، به دنبال یافتن علائم کلیدی التهاب مفصلی هستیم. یکی از مهم‌ترین این یافته‌ها که به افتراق آرتریت التهابی از غیرالتهابی کمک می‌کند، ضخیم شدن غشای سینوئیل است.

• **ضخیم شدن غشای سینوئیل (Synovial Thickening) یا سینوویت (Synovitis):**

- **تظاهر بالینی:** در لمس مفصل، به جای حس کردن ساختارهای سفت استخوانی، یک حس "خمیری"، "نرم" یا "اسفنجی" در کپسول مفصلی لمس می‌شود.
- **پاتوفیزیولوژی:** این یافته، مشخصه اصلی آرتریت‌های التهابی مانند **آرتریت روماتوئید** است. در این بیماری‌ها، غشای سینوئیل (پوشش داخلی مفصل) دچار التهاب شدید، هایپرتروفی (افزایش حجم سلول‌ها) و هایپرپلازی (افزایش تعداد سلول‌ها) می‌شود. این بافت ملتهب و ضخیم شده که به آن **پانوس (Pannus)** می‌گویند، همان چیزی است که در معاینه حس خمیری را ایجاد می‌کند.
- **اهمیت تشخیصی:** وجود سینوویت، یک مفصل را به عنوان "ملتهب" طبقه‌بندی می‌کند و آن را از شرایط غیرالتهابی مانند استئوآرتریت (که مشخصه‌اش کریپتوس و برجستگی استخوانی است) متمایز می‌سازد.

سوال 25

سوال: حرکتی که در آن کف پا به سمت **داخل** چرخانده می‌شود چه نام دارد و این حرکت عمدتاً در کدام مفصل پا رخ می‌دهد؟

- الف) اورژن (Eversion) - مفصل تیبیوتالار
- ب) اینورژن (Inversion) - مفصل ساب‌تالار
- ج) پلانتار فلکشن (Plantar flexion) - مفاصل متاتارسوفالانژیال
- د) دورسی فلکشن (Dorsiflexion) - مفصل تیبیوتالار

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (اورژن - مفصل تیبیوتالار): نادرست است.** اورژن به معنای چرخاندن کف پا به سمت **خارج** است و در مفصل ساب‌تالار رخ می‌دهد.
 - **گزینه ب (اینورژن - مفصل ساب‌تالار): صحیح است.** اینورژن دقیقاً به معنای چرخاندن کف پا به سمت **داخل** است و در برنامه به وضوح بیان می‌کند که این حرکت عمدتاً در **مفصل ساب‌تالار** (مفصل زیر استخوان تالوس) اتفاق می‌افتد.
 - **گزینه ج (پلانتار فلکشن - مفاصل متاتارسوفالانژیال): نادرست است.** پلانتار فلکشن (حرکت پا به سمت پایین) عمدتاً در مفصل اصلی مچ پا (تیبیوتالار) رخ می‌دهد.
 - **گزینه د (دورسی فلکشن - مفصل تیبیوتالار): نادرست است.** دورسی فلکشن (حرکت پا به سمت بالا) در مفصل تیبیوتالار رخ می‌دهد، اما تعریف حرکت در سوال با آن مطابقت ندارد.
-

نکته کامل از درسنامه: معاینه حرکات مچ پا و اهمیت بالینی آنها

برای تشخیص دقیق محل درگیری در مچ پا و پا، افتراق بین حرکاتی که در مفاصل مختلف این ناحیه انجام می‌شود، ضروری است.

• تعریف حرکات اصلی:

- **دورسی فلکشن (Dorsiflexion):** حرکت مچ پا به سمت بالا (نزدیک کردن روی پا به ساق).
- **پلانتار فلکشن (Plantar flexion):** حرکت مچ پا به سمت پایین (مانند فشار دادن پدال گاز).
- **اینورژن (Inversion):** چرخاندن کف پا به سمت داخل.
- **اورژن (Eversion):** چرخاندن کف پا به سمت خارج.

• اهمیت بالینی محل انجام حرکت:

- حرکات **دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن** عمدتاً در **مفصل تیبیوتالار (Tibiotalar Joint)** که مفصل اصلی مچ پا است، رخ می‌دهند. بنابراین، درد یا محدودیت در این حرکات، به نفع آسیب یا التهاب در این مفصل است.
- حرکات **اینورژن و اورژن** عمدتاً در **مفصل ساب‌تالار (Subtalar Joint)** که زیر استخوان تالوس قرار دارد، اتفاق می‌افتند. بنابراین، درد یا محدودیت در این حرکات، به نفع آسیب یا التهاب در مفصل ساب‌تالار است. این افتراق به پزشک در تعیین محل دقیق مفصل درگیر کمک شایانی می‌کند.

سوال 26

سوال: انحراف انگشتان به سمت اولنار (Ulnar Deviation) در مفاصل متاکارپوفالانژیال (MCP)، یک تغییر شکل کلاسیک و مشخصه کدام بیماری روماتولوژیک است؟

- الف) استئوآرتریت
- ب) لوپوس اریتماتوز سیستمیک
- ج) آرتریت روماتوئید
- د) آرتریت پسوریاتیک

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف، ب و د: نادرست است.** اگرچه سایر آرتریت‌ها نیز می‌توانند باعث تغییر شکل مفاصل دست شوند، اما انحراف به سمت اولنار در مفاصل MCP به طور خاص به عنوان یک یافته کلاسیک برای آرتریت روماتوئید شناخته می‌شود.
- **گزینه ج (آرتریت روماتوئید): صحیح است.** درسنامه به طور صریح و با تحلیل تصویر مربوطه، بیان می‌کند که انحراف به سمت اولنار در مفاصل MCP "یک تغییر شکل کلاسیک در آرتریت روماتوئید است."

نکته کامل از درسنامه: دفورمیتی‌های دست در آرتریت روماتوئید

التهاب مزمن و کنترل‌نشده در بیماری آرتریت روماتوئید (RA) می‌تواند به تخریب ساختارهای مفصلی (غضروف، استخوان و لیگامان‌ها) منجر شده و باعث ایجاد تغییر شکل‌های پایدار یا دفورمیتی در مفاصل شود. یکی از این تغییر شکل‌های کلاسیک در دست، انحراف اولنار است.

• دفورمیتی انحراف به سمت اولنار (Ulnar Deviation):

- **تعریف:** یک تغییر شکل مشخص است که در آن انگشتان در سطح مفاصل متاکارپوفالانژیال (MCP)، به سمت استخوان اولنا (سمت انگشت کوچک) منحرف می‌شوند.
- **پاتوفیزیولوژی:** این دفورمیتی به دلیل التهاب مزمن (سینوویت) در مفاصل MCP و آسیب به کپسول مفصلی و لیگامان‌های نگهدارنده تاندون‌ها رخ می‌دهد که باعث لغزش تاندون‌ها به سمت اولنار و کشیده شدن انگشتان به آن سمت می‌شود.
- **اهمیت بالینی:** وجود این دفورمیتی نشان‌دهنده بیماری طولانی‌مدت یا شدید است و به عنوان یک **تغییر شکل کلاسیک در آرتریت روماتوئید** شناخته می‌شود.

سوال 27

سوال: کدام یک از یافته‌های زیر در معاینه قدرت مشت کردن (Power Grip) یک یافته شایع و مهم در بیماران مبتلا به آرتریت التهابی دست است؟

- الف) افزایش قدرت مشت کردن به دلیل التهاب
- ب) عدم توانایی در باز کردن کامل انگشتان پس از مشت کردن
- ج) کاهش قدرت مشت کردن
- د) احساس کلیک کردن در مفاصل هنگام مشت کردن

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (افزایش قدرت): نادرست است.** التهاب و درد مفاصل منجر به ضعف و کاهش قدرت می‌شود، نه افزایش آن.
- **گزینه ب (عدم توانایی در باز کردن انگشتان): نادرست است.** این حالت بیشتر مشخصه "انگشت ماشه‌ای" (Trigger Finger) است که یک نوع تنوسینوویت است و یافته اصلی آرتریت مفصلی نیست.

- **گزینه ج (کاهش قدرت مشت کردن): صحیح است.** درسنامه به وضوح بیان می‌کند: "کاهش قدرت مشت کردن یک یافته شایع و مهم در بیماران مبتلا به آرتریت التهابی دست است." این کاهش قدرت به دلیل درد، تورم و آسیب به تاندون‌ها و مفاصل رخ می‌دهد.
- **گزینه د (احساس کلیک کردن): نادرست است.** کلیک کردن بیشتر در آسیب‌های مکانیکی یا آرتروز دیده می‌شود تا آرتریت‌های التهابی.

نکته کامل از درسنامه: بررسی حرکات و قدرت دست

در بخش معاینه حرکات دست، ارزیابی قدرت مشت کردن بیمار یکی از روش‌های ساده و در عین حال مهم برای سنجش عملکرد کلی دست است.

- **روش معاینه قدرت مشت کردن (Power Grip):** از بیمار خواسته می‌شود دستان خود را محکم مشت کند.
- **اهمیت بالینی:** این حرکت قدرت کلی دست و عملکرد تاندون‌های خم‌کننده (فلکسور) انگشتان را نشان می‌دهد.
- **تفسیر یافته‌ها:**
 - **کاهش قدرت مشت کردن یک یافته شایع و مهم در بیماران مبتلا به آرتریت التهابی دست، به خصوص آرتریت روماتوئید، محسوب می‌شود.**
 - **علل کاهش قدرت:** این ضعف می‌تواند ناشی از موارد زیر باشد:
 1. **درد و تورم** مفاصل MCP و PIP که مانع از خم شدن کامل و قدرتمند انگشتان می‌شود.
 2. **التهاب غلاف تاندون‌ها (تنوسینوویت)** که حرکت تاندون‌های فلکسور را مختل می‌کند.
 3. **آسیب ساختاری** به مفاصل و تاندون‌ها در مراحل پیشرفته بیماری.

سوال 28

سوال: خانمی ۲۰ ساله با ضایعات پوستی شدیداً حساس به نور و آرتریت مفاصل MCP مراجعه کرده است. در آزمایشات، آنتی‌بادی Anti-Ro/SSA مثبت است. کدام یک از ضایعات پوستی زیر با این شرح حال بیشترین تطابق را دارد؟

- الف) راش پروانه‌ای حاد روی گونه‌ها
- ب) پلاک‌های قرمز رنگ حلقوی با مرکز رنگ‌پریده در نواحی در معرض آفتاب
- ج) پلاک‌های قرمز با مرکز آتروفیک و اسکار روی پیشانی
- د) شیارهای شعاعی اطراف دهان

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (راش پروانه‌ای حاد): نادرست است.** این راش مشخصه لوپوس پوستی حاد (ACLE) است که اگرچه حساس به نور است، اما ارتباط آن با ضایعات حلقوی و آنتی‌بادی Anti-Ro به اندازه گزینه "ب" قوی نیست.
- **گزینه ب (پلاک‌های قرمز رنگ حلقوی): صحیح است.** این توصیف دقیقاً با فرم حلقوی (Annular) **لوپوس پوستی تحت حاد (SCLE)** مطابقت دارد. طبق درسنامه، این فرم به شدت حساس به نور است، اسکار به جا نمی‌گذارد و مهم‌تر از همه، به شدت با وجود آنتی‌بادی Anti-Ro/SSA در خون مرتبط است.
- **گزینه ج (پلاک‌های قرمز با اسکار): نادرست است.** این توصیف مشخصه لوپوس دیسکوئید (DLE) یا فرم مزمن است که باعث ایجاد اسکار و آتروفی می‌شود.
- **گزینه د (شیارهای شعاعی اطراف دهان): نادرست است.** این یافته مشخصه بیماری اسکلرودرمی است.

نکته کامل از درسنامه: لوپوس پوستی تحت حاد (Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus) (- SCLE)

این فرم از لوپوس پوستی بین فرم حاد (ACLE) و مزمن (DLE) قرار می‌گیرد و ویژگی‌های مشخصی دارد:

- **حساسیت شدید به نور (Photosensitivity):** ضایعات معمولاً در نواحی در معرض آفتاب مانند بالای کمر، شانه‌ها، و بازوها دیده می‌شوند.
- **شکل ظاهری ضایعات:** ضایعات SCLE به دو شکل اصلی ظاهر می‌شوند:
 1. **حلقوی (Annular):** پلاک‌های قرمز، کمی برجسته و حلقوی شکل که مرکز آن‌ها رنگ‌پریده است.
 2. **پاپولواسکوموس (Papulosquamous):** پلاک‌های قرمز و پوسته‌دار که ممکن است شبیه به بیماری پسوریازیس باشند.
- **عدم ایجاد اسکار:** یک نکته بالینی مهم این است که این ضایعات معمولاً پس از بهبودی، جای زخم (اسکار) یا آتروفی به جا نمی‌گذارند.
- **ارتباط سرولوژیک:** این فرم از لوپوس پوستی ارتباط بسیار قوی با وجود آنتی‌بادی Anti-Ro/SSA در خون بیمار دارد.
- **لوپوس نوزادی (Neonatal Lupus):** انتقال آنتی‌بادی Anti-Ro/SSA از مادر به جنین می‌تواند باعث ایجاد ضایعات پوستی SCLE و همچنین مشکلات قلبی (بلوک قلبی) در نوزاد شود.

سوال 29

سوال: برای معاینه مفصل گیجگاهی-فکی (TMJ)، انگشتان معاینه‌کننده در کدام ناحیه قرار می‌گیرد و به دنبال کدام یافته‌ها هستیم؟

- الف) روی عضله ماستر - به دنبال اسپاسم عضلانی
- ب) داخل مجرای گوش - به دنبال درد ارجاعی

- (ج) جلوی تراگوس گوش - به دنبال تندرns، کلیک و کریپتوس
- (د) زیر زاویه فک - به دنبال تورم غدد لنفاوی

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف و ب و د: نادرست است.** محل صحیح قرارگیری انگشتان برای لمس مستقیم مفصل TMJ، جلوی تراگوس گوش است.
- **گزینه ج (جلوی تراگوس گوش - به دنبال تندرns، کلیک و کریپتوس): صحیح است.** درسنامه دقیقاً همین روش را توصیف می‌کند: انگشتان جلوی برجستگی غضروفی جلوی مجرای گوش (تراگوس) قرار گرفته و از بیمار خواسته می‌شود دهان خود را باز و بسته کند. در این حین، معاینه‌کننده به دنبال حساسیت به لمس (تندرns)، صدای "تق" (کلیک)، صدای سایش (کریپتوس) و کاهش دامنه حرکتی است.

نکته کامل از درسنامه: معاینه مفصل گیجگاهی-فکی (Temporomandibular Joint - TMJ)

مفصل TMJ مفصلی است که فک پایین را به جمجمه متصل می‌کند و در فرآیند جویدن و صحبت کردن نقش حیاتی دارد. این مفصل نیز می‌تواند در بیماری‌های روماتولوژیک درگیر شود.

- **روش معاینه:**
 - **محل قرارگیری انگشتان:** معاینه‌کننده دو انگشت اول هر دست خود را دقیقاً در **جلوی تراگوس گوش** (برجستگی غضروفی کوچک که جلوی مجرای گوش قرار دارد) قرار می‌دهد. در این نقطه می‌توان حرکت کندیل فک را لمس کرد.
 - **انجام مانور:** از بیمار خواسته می‌شود که دهان خود را به آرامی **باز و بسته کند**.
 - **یافته‌های مورد انتظار:** در حین انجام این مانور، باید به دنبال علائم زیر بود:
 - **تندرns (Tenderness):** حساسیت یا درد در هنگام لمس مفصل.
 - **کلیک کردن (Clicking):** شنیدن یا لمس صدای "تق" که ممکن است ناشی از جابجایی دیسک مفصلی باشد.
 - **کریپتوس (Crepitus):** حس یا صدای سایش و "خرخر" که معمولاً نشان‌دهنده تغییرات تخریبی (آرتروز) در سطح مفصل است.
 - **کاهش دامنه حرکتی:** عدم توانایی بیمار در باز کردن کامل دهان.

30 سوال

سوال: آتروفی یا تحلیل رفتن عضلات در بیماری‌های مفصلی روماتولوژیک به چه دلایلی رخ می‌دهد؟

- الف) فقط به دلیل آسیب مستقیم بیماری التهابی به عضله
- ب) فقط به دلیل آسیب عصبی ناشی از تحت فشار قرار گرفتن عصب
- ج) به دلیل عدم استفاده از عضله به خاطر درد و محدودیت حرکتی (Disuse Atrophy) یا آسیب مستقیم بیماری
- د) همیشه به دلیل پارگی تاندون‌های متصل به عضله است

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف و ب: نادرست است.** این گزینه‌ها تنها یکی از دلایل احتمالی را ذکر می‌کنند، در حالی که آتروفی می‌تواند علل متعددی داشته باشد.
- **گزینه ج (به دلیل عدم استفاده از عضله یا آسیب مستقیم بیماری): صحیح است.** درسنامه به وضوح دو مکانیسم اصلی را برای آتروفی عضلانی ذکر می‌کند: ۱) **آتروفی ناشی از عدم استفاده (Disuse Atrophy)** که به خاطر درد و محدودیت حرکتی مفصل رخ می‌دهد و ۲) **آسیب مستقیم به عصب یا عضله** توسط خود بیماری التهابی.
- **گزینه د: نادرست است.** پارگی تاندون یکی از علل آتروفی است اما تنها علت آن نیست و همیشه رخ نمی‌دهد.

نکته کامل از درسنامه: آتروفی عضلانی (Muscle Wasting)

آتروفی یا تحلیل رفتن عضلات اطراف یک مفصل درگیر، یک یافته شایع در معاینات روماتولوژی است. این وضعیت می‌تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود:

1. **آتروفی ناشی از عدم استفاده (Disuse Atrophy):** این شایع‌ترین مکانیسم است. وقتی یک مفصل به دلیل **درد، التهاب و محدودیت حرکتی** به درستی استفاده نمی‌شود، عضلات مرتبط با آن مفصل به تدریج ضعیف و کوچک می‌شوند. این یک پاسخ فیزیولوژیک به بی‌حرکتی است.
2. **آسیب مستقیم ناشی از بیماری:**
 - **آسیب به عضله:** در بیماری‌هایی مانند درماتومیوزیت، خود فرآیند التهابی مستقیماً به فیبرهای عضلانی حمله کرده و باعث تخریب و آتروفی آن‌ها می‌شود.
 - **آسیب به عصب:** بیماری التهابی یا فشار ناشی از تورم مفصل می‌تواند به اعصاب حرکتی که به عضله عصب‌دهی می‌کنند، آسیب برساند. قطع ارتباط عصب با عضله (دنرواسیون) منجر به تحلیل سریع عضله می‌شود (مانند آتروفی تنار در سندرم تونل کارپال شدید).
3. **پارگی تاندون:** در مواردی مانند پارگی تاندون‌های روتاتور کاف شانه، عضله‌ای که تاندون آن پاره شده است، دیگر نمی‌تواند عملکرد خود را انجام دهد و به مرور زمان دچار آتروفی می‌شود.

بنابراین، مشاهده آتروفی عضلانی یک یافته مهم است که می‌تواند نشان‌دهنده مزمن بودن، شدت بیماری یا وجود عوارض خاصی مانند آسیب عصبی یا پارگی تاندون باشد.

سوال 31

سوال: زخم‌های دردناک و دیرجوش در نوک انگشتان (Fingertip Ulcerations) که در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی دیده می‌شود، عمدتاً ناشی از کدام مکانیسم پاتوفیزیولوژیک است؟

- الف) رسوب کلسیم در زیر پوست (کلسینوزیس کوتیس)
- ب) عفونت‌های باکتریایی ثانویه به دلیل ترک‌های پوستی
- ج) حملات مکرر و شدید پدیده رینود و کاهش خون‌رسانی (ایسکمی)
- د) آسیب مکانیکی به پوست به دلیل سفت شدن و کاهش حس

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (رسوب کلسیم): نادرست است.** کلسینوزیس کوتیس یک تظاهر دیگر اسکلرودرمی است اما علت اصلی ایجاد زخم‌های ایسکمیک نیست.
- **گزینه ب (عفونت‌های باکتریایی): نادرست است.** اگرچه این زخم‌ها می‌توانند به صورت ثانویه عفونی شوند، اما علت اولیه ایجاد آن‌ها عفونت نیست.
- **گزینه ج (حملات مکرر پدیده رینود): صحیح است.** درسنامه به وضوح مکانیسم ایجاد این زخم‌ها را توضیح می‌دهد: "حملات مکرر و شدید پدیده رینود (Raynaud's phenomenon) ... باعث اسپاسم شدید عروق و کاهش خون رسانی (ایسکمی) به نوک انگشتان می‌شود. این ایسکمی مزمن منجر به نکروز بافتی و ایجاد زخم می‌گردد."
- **گزینه د (آسیب مکانیکی): نادرست است.** علت اصلی زخم، آسیب عروقی و ایسکمی است، نه صرفاً آسیب مکانیکی.

نکته کامل از درسنامه: تظاهرات پوستی و اسکلتی دست در اسکلرودرمی

اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک) با فیبروز پوست و آسیب عروق کوچک مشخص می‌شود. این تغییرات منجر به یافته‌های کلاسیک در دست‌ها می‌شود.

- **اسکلروداکتیلی (Sclerodactyly):** پوست انگشتان ضخیم، سفت، براق و مومی شکل می‌شود.
- **کونتراکچر انگشتان (Contracted fingers):** به دلیل سفت شدن پوست و بافت‌های نرم، انگشتان در حالت خمیده (فلکشن) باقی می‌مانند.
- **زخم‌های نوک انگشتان (Fingertip Ulcerations):**

- **تظاهر بالینی:** زخم‌های بسیار دردناک و دیرجوش که در نوک انگشتان ایجاد می‌شوند. پس از بهبودی، ممکن است اسکارهای حفره‌ای یا ستاره‌ای شکل به جا بگذارند.
- **مکانیسم پاتوفیزیولوژی:** علت اصلی این زخم‌ها، **پدیده رینود** است که در بیماران اسکلوئیدرمی شایع و شدید می‌باشد. حملات مکرر رینود باعث اسپاسم شدید عروق انگشتان شده و خون‌رسانی به نوک آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد (ایسکمی). این **ایسکمی مزمن** در نهایت منجر به مرگ بافت (نکروز) و ایجاد زخم می‌شود.
- **اکرواستئولیز (Acro-osteolysis):** ایسکمی مزمن همچنین می‌تواند باعث تحلیل رفتن استخوان بند انتهایی انگشتان شود که به باریک و کوتاه شدن انگشتان می‌انجامد.

سوال 32

سوال: کدام فرم از لوپوس پوستی به عنوان فرم مزمن شناخته می‌شود که مشخصه اصلی آن ایجاد اسکار و آتروفی (تحلیل رفتن پوست) است و می‌تواند مخاط دهان را نیز درگیر کند؟

- الف) لوپوس پوستی حاد (ACLE)
- ب) لوپوس پوستی تحت حاد (SCLE)
- ج) لوپوس دیسکوئید (DLE)
- د) لوپوس نوزادی

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (لوپوس پوستی حاد - ACLE): نادرست است.** این فرم با راش پروانه‌ای حاد و بدون اسکار مشخص می‌شود.
- **گزینه ب (لوپوس پوستی تحت حاد - SCLE): نادرست است.** این فرم نیز معمولاً اسکار به جا نمی‌گذارد.
- **گزینه ج (لوپوس دیسکوئید - DLE): صحیح است.** درسنامه به طور مشخص بیان می‌کند: "لوپوس دیسکوئید فرم مزمن لوپوس پوستی است که معمولاً باعث ایجاد اسکار و آتروفی (تحلیل رفتن پوست) می‌شود." همچنین به درگیری مخاط دهان در این فرم اشاره می‌کند.
- **گزینه د (لوپوس نوزادی): نادرست است.** این حالت ناشی از انتقال آنتی‌بادی از مادر به نوزاد است و ضایعات آن معمولاً شبیه SCLE بوده و بدون اسکار بهبود می‌یابند.

نکته کامل از درسنامه: لوپوس دیسکوئید (Discoid Lupus Erythematosus - DLE)

لوپوس دیسکوئید فرم **مزمن** لوپوس پوستی است و تظاهرات مشخصی دارد که آن را از سایر فرم‌ها متمایز می‌کند.

- **ویژگی اصلی:** برخلاف فرم حاد و تحت حاد، ضایعات لوپوس دیسکوئید معمولاً با آسیب دائمی به پوست همراه هستند و باعث ایجاد اسکار (جای زخم) و آتروفی (تحلیل رفتن و نازک شدن پوست) می‌شوند.
- **تظاهر پوستی:** ضایعات معمولاً به صورت پلاک‌های قرمز رنگ، با پوسته‌ریزی و حاشیه مشخص ظاهر می‌شوند. این ضایعات می‌توانند در نواحی در معرض آفتاب مانند صورت، پوست سر و گوش‌ها ایجاد شوند. درگیری پوست سر می‌تواند منجر به ریزش موی دائمی در محل اسکار شود.
- **درگیری مخاطی (Mucosal DLE):**
 - لوپوس دیسکوئید می‌تواند مخاط دهان یا لب‌ها را نیز درگیر کند.
 - ضایعات مخاطی به صورت پلاک‌های قرمز رنگ، گاهی با حاشیه یا خطوط سفید شعاعی (شبیه به لیکن پلان) ظاهر می‌شوند.
 - این ضایعات می‌توانند زخمی، دردناک و یا آتروفیک شوند.
- **پاتوفیزیولوژی:** یک واکنش التهابی مزمن با واسطه سلول‌های T علیه اپیتلیوم پوست و مخاط که منجر به آسیب و تخریب بافت می‌شود.

سوال 33

سوال: تقارن (Symmetry) در درگیری مفاصل یکی از سرخ‌های مهم تشخیصی است. کدام بیماری روماتولوژیک به طور معمول الگوی درگیری متقارن دارد؟

- الف) نفرس
- ب) آرتریت پسوریاتیک
- ج) آرتریت روماتوئید
- د) استئوآرتریت

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (نفرس): نادرست است.** حملات حاد نفرس معمولاً به صورت مونوآرتریت (درگیری یک مفصل) و غیرمتقارن شروع می‌شود.
- **گزینه ب (آرتریت پسوریاتیک): نادرست است.** آرتریت پسوریاتیک می‌تواند الگوهای مختلفی داشته باشد، اما الگوی کلاسیک آن اغلب غیرمتقارن است.
- **گزینه ج (آرتریت روماتوئید): صحیح است.** درسنامه به طور مشخص در بخش "مشاهده و بررسی کلی" بیان می‌کند: "بررسی تقارن درگیری مفاصل، برای مثال آرتریت روماتوئید معمولاً الگوی درگیری متقارن دارد."

- **گزینه د (استئوآرتريت): نادرست است.** استئوآرتريت اغلب به صورت غيرمتقارن مفاصل را درگير مي‌کند، به خصوص در مراحل اوليه.

نکته کامل از درسنامه: اهميت تقارن در معاينه روماتولوژی

یکی از اصول مهم در معاينه باليني مفاصل، بررسی **تقارن (Symmetry)** درگیری است. مشاهده اینکه آیا مفاصل مشابه در دو طرف بدن به صورت همزمان درگير شده‌اند یا خير، می‌تواند یک سرنخ تشخيصی بسيار قوي باشد.

- **الگوی درگیری متقارن (Symmetrical Pattern):**

- **تعريف:** التهاب یا آسیب در مفاصل مشابه در هر دو طرف بدن (مثلاً هر دو مچ دست، یا مفاصل MCP هر دو دست).
- **بیماری شاخص: آرتريت روماتوئيد (RA)** بیماری کلاسیکی است که معمولاً با یک پلي‌آرتريت التهابی متقارن تظاهر می‌کند. این ویژگی یکی از مشخصه‌های اصلی این بیماری است و به افتراق آن از ساير انواع آرتريت کمک می‌کند.

- **الگوی درگیری غيرمتقارن (Asymmetrical Pattern):**

- **تعريف:** درگیری مفاصل به صورت نامنظم و بدون تطابق در دو طرف بدن (مثلاً درگیری زانوی راست و مچ پای چپ).
- **بیماری‌های مرتبط:**
 - **اسپوندیلوآرتريت‌ها:** مانند **آرتريت پسورياتیک** و **آرتريت راکتیو** که اغلب الگوی الیگوآرتريت (درگیری ۲ تا ۴ مفصل) غيرمتقارن دارند.
 - **نقرس:** معمولاً به صورت مونوآرتريت (درگیری یک مفصل) حاد و غيرمتقارن شروع می‌شود.
 - **استئوآرتريت:** معمولاً به صورت غيرمتقارن پیشرفت می‌کند.

سوال 34 (از فایل: فیزیوپاتولوژی_روماتولوژی،_مهر_93)

سوال: بیمار خانم ۳۲ ساله سه ماه بعد از زایمان با درد مچ دست در ناحیه رادیال مراجعه کرده است. درد بیمار با فعالیت بدتر می‌شود. در معاینه تندرns در لترال مچ دارد که با خم کردن شست داخل مشت و انحراف آن به سمت اولنار تشدید می‌یابد. تست تینل و فالن منفی است. تشخيص شما چیست؟

- الف) سندروم تونل کارپال
- ب) آرتروز متاکارپوفالانژیال اول
- ج) تنوسینوویت دکوروان
- د) آرتريت روماتوئيد

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (سندروم تونل کارپال): نادرست است.** درد در سندرم تونل کارپال بیشتر با علائم عصبی (گزگز و بی‌حسی) همراه است و تست‌های فالن و تینل مثبت می‌شوند که در این بیمار منفی گزارش شده است.
- **گزینه ب (آرتروز متاکارپوفالانژیال اول): نادرست است.** آرتروز این مفصل (قاعده شست) معمولاً باعث درد در قاعده شست می‌شود و مانور توصیف شده برای آن تشخیصی نیست.
- **گزینه ج (تنوسینوویت دکوروان): صحیح است.** شرح حال (درد ناحیه رادیال مچ دست پس از زایمان) و یافته معاینه (تشدید درد با مانور خم کردن شست در مشت و انحراف اولنار) دقیقاً مطابق با توصیف کلاسیک **تست فینکل‌اشتاین (Finkelstein's test)** برای تشخیص تنوسینوویت دکوروان است.
- **گزینه د (آرتریت روماتوئید): نادرست است.** آرتریت روماتوئید معمولاً باعث آرتریت (التهاب مفصل) می‌شود نه تنوسینوویت (التهاب غلاف تاندون) به این شکل لوکالیزه، و اغلب با درگیری متقارن سایر مفاصل همراه است.

نکته کامل از درسنامه: تنوسینوویت دکوروان (De Quervain's Tenosynovitis)

این بیماری یکی از علل شایع درد مچ دست است که در درسنامه به آن اشاره شده است.

- **تعریف:** تنوسینوویت دکوروان، **التهاب غلاف تاندون** است نه التهاب خود مفصل. این بیماری تاندون‌های سمت شست مچ دست را که مسئول دور کردن و باز کردن شست هستند، درگیر می‌کند.
- **علت و شیوع:** این حالت اغلب به دلیل استفاده بیش از حد و حرکات تکراری مچ و شست رخ می‌دهد و در مادران جوان (به دلیل بلند کردن نوزاد) شایع است.
- **علائم:** درد و حساسیت (تندرنس) در سمت رادیال (سمت شست) مچ دست که با حرکت دادن شست تشدید می‌شود.
- **تست تشخیصی (تست فینکل‌اشتاین):**
 - **روش انجام:** از بیمار خواسته می‌شود انگشت شست خود را داخل چهار انگشت دیگر مشت کند. سپس معاینه‌کننده به آرامی مچ دست بیمار را به سمت اولنار (سمت انگشت کوچک) منحرف می‌کند.
 - **تفسیر:** ایجاد درد شدید در ناحیه رادیال مچ دست در حین این مانور، تست را مثبت کرده و قویاً به نفع تشخیص تنوسینوویت دکوروان است.

